Perfil V3 · código por código

Dermatología

Los 60 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Dermatología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 33 códigos

6.01.1.001 Acné

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.2 Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína

QUÉ HAY QUE SABER

- Acné vulgar: comedones (abiertos/cerrados) + pápulas, pústulas o nódulos en cara, pecho y espalda; el comedón es la lesión que lo define. Fisiopatología: hiperqueratinización folicular, exceso de sebo (andrógenos) y Cutibacterium acnes.
- Escalonamiento: comedoniano → retinoide tópico (adapaleno 0,1 %, de noche) ± peróxido de benzoilo; pápulo-pustuloso leve-moderado → peróxido de benzoilo + retinoide ± clindamicina tópica.
- Nunca antibiótico tópico en monoterapia (resistencia en semanas). Pápulo-pustuloso moderado-severo o extenso: doxiciclina o minociclina oral 8–12 semanas junto a peróxido de benzoilo (fotosensibilidad, esofagitis; contraindicadas en embarazo y <8 años).
- Isotretinoína oral: acné nódulo-quístico/conglobata, con cicatrices o refractario tras ciclo completo de antibiótico oral. Teratógeno extremo: doble anticoncepción desde 1 mes antes hasta 1 mes después, test de embarazo previo y mensual; control de perfil lipídico y hepático; queilitis es efecto esperado.
- Seguimiento completo por el médico general: evaluar respuesta a 8–12 semanas, escalar si no responde y derivar a dermatología los casos con cicatrices o candidatos a isotretinoína.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 78

Paciente de 17 años consulta por acné. Al examen físico se observan múltiples comedones en cara, pecho y espalda, asociados a pápulas y pústulas abundantes, y presencia de algunos quistes en dichas zonas con cicatrices atróficas. **¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?**

A) Peróxido de benzoilo tópico
B) Clindamicina tópica
C) Isotretinoína oral
D) Doxiciclina oral
E) Adapaleno tópico

Respuesta C. Comedones extensos, pápulas y pústulas abundantes, con quistes y cicatrices atróficas: acné nódulo-quístico, inflamatorio severo. El tratamiento de elección es la isotretinoína oral. Las demás opciones son escalones tópicos u orales insuficientes para este grado de severidad y de cicatrización.

Pregunta de práctica

Joven de 17 años consulta por lesiones faciales de 6 meses de evolución que le generan angustia social. Al examen físico se aprecian abundantes comedones abiertos y cerrados en frente y mejillas, con escasas pápulas eritematosas no confluentes, sin nódulos, quistes ni cicatrices. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A) Adapaleno tópico en gel, aplicado en la noche
B) Doxiciclina oral 100 mg al día por 8 semanas
C) Clindamicina tópica en monoterapia
D) Isotretinoína oral en dosis bajas
E) Corticoide tópico de baja potencia

Respuesta A. Comedones predominantes con escasas pápulas no confluentes, sin nódulos ni cicatrices: acné comedoniano leve. El tratamiento de primera línea es un retinoide tópico, como el adapaleno, aplicado en la noche; puede asociarse peróxido de benzoilo. No corresponden antibióticos orales, isotretinoína ni la clindamicina en monoterapia.

6.01.1.002 Alopecías

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.4 Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer paso: examinar el cuero cabelludo. Orificios foliculares conservados = alopecia no cicatricial (potencialmente reversible); piel lisa y brillante sin orificios = cicatricial (irreversible; lupus discoide, liquen plano pilar) y requiere biopsia precoz.

- Androgenética (la más frecuente): miniaturización por DHT. Hombre: entradas y vértex (Hamilton-Norwood); mujer: raya central ensanchada con línea frontal respetada (Ludwig).
- Areata: placa redonda, lisa, sin eritema ni descamación, con pelos «en signo de exclamación» en el borde; autoinmune, se asocia a tiroiditis y vitíligo. Efluvio telógeno: caída difusa 2–3 meses tras parto, cirugía, fiebre, déficit de fierro o baja de peso brusca; tracción positiva difusa.
- Tratamiento inicial: androgenética minoxidil tópico 2–5 % ± finasteride oral (contraindicado en mujer fértil); areata en placas corticoide intralesional (triamcinolona) o tópico muy potente; efluvio telógeno solo tranquilizar (se resuelve en ~6 meses) y corregir la causa (fierro, TSH).
- Seguimiento: derivar a dermatología las alopecias cicatriciales, areata extensa (total/universal), sin respuesta o con diagnóstico dudoso. Descartar tiña capitis en niños con placa descamativa.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 151

Un paciente de 19 años consulta por caída de cabello en la zona occipital, que inició hace 2 semanas. Al examen físico se aprecia una zona sin cabellos, redondeada y de piel lisa, sin eritema ni descamación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Lupus eritematoso cutáneo crónico
B) Alopecia areata
C) Alopecia androgénica
D) Tricotilomanía
E) Tiña capitis

Respuesta B. Zona alopécica única, de aparición reciente, de piel lisa sin eritema ni descamación, en un joven de 19 años: alopecia areata. El lupus discoide es cicatricial y de curso más lento; la androgenética no aparece así de rápido ni en placa única a esta edad; la tricotilomanía muestra pelos rotos irregulares por arrancamiento; la tiña capitis suele tener descamación.

Pregunta de práctica

Mujer de 32 años consulta 3 meses después de dar a luz, porque nota caída masiva del cabello al peinarse y en la almohada. Al examen no hay placas alopécicas circunscritas; el cuero cabelludo es normal, con orificios foliculares conservados, y la prueba de tracción es positiva de forma difusa en toda la cabeza. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar minoxidil tópico al 5 % de inmediato
B) Solicitar biopsia de cuero cabelludo con urgencia
C) Tranquilizar a la paciente y explicar que se resolverá en unos meses
D) Indicar corticoide intralesional en el vértex
E) Iniciar finasteride oral 1 mg al día

Respuesta C. Caída difusa, sin placas circunscritas, con tracción positiva generalizada y 3 meses después del parto: efluvio telógeno agudo puerperal. Es benigno y autolimitado; la conducta es tranquilizar a la paciente. La biopsia es para la alopecia cicatricial, el corticoide intralesional para la areata, y el minoxidil o el finasteride para la androgenética; ninguno corresponde aquí.

6.01.1.003 Cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular y espinocelular)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.14 Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Basocelular (75–80 %): pápula o nódulo perlado, translúcido, con telangiectasias y borde arrollado; puede ulcerarse al centro (úlcera de Rodent, forma nódulo-ulcerativa, 60 %). Variantes superficial (placa eritematodescamativa en tronco) y morfeiforme (placa amarillenta tipo cicatriz, la más agresiva localmente). Metástasis casi nulas (<0,01 %), pero destruye localmente (cartílago, hueso, órbita). Asociado a quemaduras solares intermitentes en la infancia; es el tumor palpebral maligno más frecuente.
- Espinocelular (15–20 %): placa o nódulo indurado, hiperqueratósico, costroso, que sangra o se ulcera; nace sobre queratosis actínica o queilitis actínica; depende de la dosis acumulada de sol (trabajadores al aire libre) y de la inmunosupresión (trasplantados, riesgo ~65 veces mayor).
- Riesgo de metástasis del espinocelular: 2–5 % en piel y hasta 15–20 % en labio inferior y pabellón auricular (invasión perineural y ganglios regionales).

- Manejo inicial: sospechar ante lesión que no cicatriza en 4 semanas o crece, en zona fotoexpuesta; biopsia diagnóstica y derivación. El tratamiento curativo es la extirpación quirúrgica con margen oncológico; cirugía micrográfica de Mohs en cara y zonas críticas.
- Seguimiento: derivar a dermatología/cirugía (cáncer de piel no melanoma); de por vida control de piel por riesgo de nuevos tumores y fotoprotección estricta.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 80

Un hombre de 70 años, consulta por una lesión en la mano derecha, que apareció hace 6 meses y que ha crecido progresivamente. Es dolorosa y se ulcera y sangra con facilidad. Al examen físico se aprecia una lesión escamosa, ulcerada, de 2 cm de diámetro. Como antecedente, trabajó por 20 años, como minero, en la región de Tarapacá. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Carcinoma espinocelular
B) Carcinoma basocelular
C) Melanoma maligno
D) Granuloma piógeno
E) Queratosis actínica

Respuesta A. Lesión escamosa, ulcerada, dolorosa y sangrante, con antecedente de décadas de fotoexposición como minero: carcinoma espinocelular clásico. El granuloma piógeno sangra mucho, pero tiene un aspecto rojo y húmedo, no escamoso.

Pregunta de práctica

Hombre de 74 años, jubilado, ex trabajador agrícola, consulta por una lesión en el labio inferior de 4 meses de evolución que no cicatriza. Al examen se observa una placa de 1 cm, de base indurada, cubierta por una costra hiperqueratósica amarillenta adherente, que sangra al desprenderse. No se palpan adenopatías submentonianas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué característica obliga a un seguimiento estricto?**

A) Carcinoma basocelular; el riesgo de metástasis es prácticamente nulo
B) Carcinoma espinocelular; el labio inferior es una localización de alto riesgo metastásico
C) Queilitis actínica simple; basta con fotoprotección
D) Herpes labial recidivante; tratar con aciclovir tópico
E) Chancro sifilítico; solicitar serología para sífilis

Respuesta B. Placa indurada, costrosa y ulcerada que no cicatriza en el labio inferior de un paciente con antecedente de exposición solar acumulada: carcinoma espinocelular. El labio inferior es una localización de alto riesgo de metástasis ganglionar (hasta 15-20%), a diferencia del carcinoma basocelular, que casi nunca metastiza.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 88 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 84 años consulta por aparición de una lesión en la zona supraciliar izquierda, hace 12 meses, pruriginosa, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se observa lo siguiente: FOTO (Mujer adulta mayor con lesión ulcerada en la zona supraciliar, borde eritematoso, de 1 cm de diámetro aprox.). El diagnóstico más probable es:

A) Carcinoma basocelular
B) Queratosis actínica
C) Queratosis seborreica
D) Granuloma piógeno
E) Melanoma acrómico

Respuesta A. Diagnóstico: Carcinoma basocelular (opción A). Si bien la imagen no era un cáncer basocelular clásico, esa era la única respuesta aceptable.. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 84 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 83 años, calvo, con antecedente de múltiples queratosis actínicas en la cabeza, presenta una lesión en el cuero cabelludo, que notó hace 3 meses y que ha ido creciendo hasta alcanzar un diámetro de 2 x 3 cm. Se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Melanoma
B) Impétigo
C) Dermatitis de contacto
D) Quemadura solar
E) Carcinoma espinocelular

Respuesta E. Tanto por las queratosis actínicas (premalignas, que evolucionan a cáncer espinocelular) como por la imagen, tiene un cáncer espinocelular.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 111 · texto original del banco, sin revisar

IMAGEN: Calvo con antecedente de queratosis actínica, muestran lesión en cabeza: a. Carcinoma espinocelular

A) Derrame pleural
B) Neumotórax
C) Neumonía
D) Atelectasia
E) Masa pulmonar

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Derrame pleural). La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 63 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 58 consulta por aparición de una lesión pruriginosa, de 3 meses de evolución en el párpado inferior derecho, que ha aumentado de volumen. Al examen físico, se observa lo siguiente: Foto 5 (https://martindevoto.com/XXXXXXXXXXX-foto/). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Orzuelo
B) Verruga vulgar
C) Herpes simplex
D) Carcinoma basocelular
E) Chalazión

Respuesta D. Diagnóstico: Carcinoma basocelular (opción D). Es un cáncer basocelular clásico.. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

6.01.1.004 Dermatitis atópica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.6 Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis atópica: eccema pruriginoso crónico recidivante (el prurito intenso es criterio cardinal, Hanifin-Rajka) con xerosis, por defecto de barrera (filagrina) y respuesta Th2/IgE; marcha atópica (asma, rinitis, alergia alimentaria).
- Topografía por edad: lactante <2 años mejillas, cuero cabelludo y superficies extensoras, eccema exudativo, respeta el área del pañal; 2–12 años pliegues antecubitales y poplíteos; adulto pliegues, cuello, manos y liquenificación.
- Tratamiento completo: emolientes diarios (técnica de mojar y sellar tras baño corto tibio), jabón syndet, ropa de algodón. Brote: corticoide tópico según zona (cara/pliegues baja potencia, hidrocortisona 1 % o tacrolimus; tronco y extremidades mediana-alta potencia como betametasona 7–14 días); antihistamínico sedante nocturno si interfiere con el sueño.
- Complicaciones: impetiginización por S. aureus (costras melicéricas: mupirocina tópica o cefadroxilo oral); eccema herpético de Kaposi (vesículas umbilicadas + fiebre) es urgencia: hospitalizar y aciclovir EV.
- Seguimiento: derivar a dermatología los casos moderados-severos refractarios (fototerapia, inmunosupresores, biológicos), con complicaciones o diagnóstico dudoso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 7 meses es traído por su madre por presentar lesiones rojas muy pruriginosas en ambas mejillas que le impiden dormir. Al examen físico se aprecia eritema brillante exudativo con pequeñas vesículas y costras en ambas mejillas, respetando el área perioral, y lesiones similares en las caras extensoras de brazos y piernas. Al desvestirlo, la piel de toda la región glútea e inguinal cubierta por el pañal está completamente sana. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar fórmula con proteína hidrolizada de forma inmediata
B) Baños cortos con syndet, emolientes e hidrocortisona tópica al 1 % en las mejillas
C) Iniciar aciclovir endovenoso de urgencia
D) Indicar betametasona tópica de alta potencia en toda la cara
E) Solicitar biopsia cutánea para confirmar el diagnóstico

Respuesta B. Eccema exudativo pruriginoso en mejillas, respetando estrictamente el pañal, en un lactante: dermatitis atópica del lactante. La conducta es cuidados generales de la piel más un corticoide de baja potencia en la cara. La betametasona de alta potencia en la cara produce atrofia; el aciclovir es para el eccema herpético, que aquí no hay signos de; y la biopsia no es necesaria en un cuadro tan característico.

6.01.1.005 Dermatitis del pañal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis irritativa del pañal: eritema, descamación o erosiones en convexidades (glúteos, genitales, zona perineal) que respeta los pliegues; causada por humedad, orina/deposiciones y fricción.
- Sobreinfección por Candida: eritema rojo intenso y brillante que compromete los pliegues inguinales, con pápulas, pústulas y lesiones satélites; sospechar si persiste >3 días pese a tratamiento.
- Tratamiento completo: cambios frecuentes de pañal, aseo suave con agua o aceite (sin toallitas con alcohol), dejar zona al aire, pasta de óxido de zinc o vaselina como barrera en cada cambio.
- Si hay Candida: antifúngico tópico (clotrimazol o nistatina) 2–3 veces al día hasta 1–2 semanas. Evitar corticoides potentes en la zona del pañal (absorción y atrofia); hidrocortisona 1 % solo en ciclos cortos si hay inflamación marcada.
- Seguimiento completo por médico general; reconsiderar diagnóstico (dermatitis seborreica, psoriasis del pañal, acrodermatitis enteropática, histiocitosis) si no responde.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 7 meses con eritema en la zona del pañal de 10 días que no mejoró con pasta de óxido de zinc. Al examen hay eritema rojo intenso, brillante, que compromete los pliegues inguinales, con pápulas y pústulas satélites en la periferia. **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento más adecuado?**

A) Dermatitis irritativa del pañal; corticoide de alta potencia
B) Psoriasis del pañal; calcipotriol
C) Dermatitis del pañal sobreinfectada por Candida; antifúngico tópico (clotrimazol o nistatina) y medidas de cuidado del pañal
D) Impétigo; cefadroxilo oral
E) Dermatitis seborreica; ketoconazol oral

Respuesta C. La dermatitis irritativa del pañal respeta los pliegues. El compromiso de pliegues con eritema intenso y lesiones satélites indica sobreinfección por Candida, frecuente tras más de 3 días de evolución. Se trata con antifúngico tópico, cambios frecuentes, aseo suave y pasta barrera. Los corticoides potentes están contraindicados en esta zona.

6.01.1.006 Dermatitis seborreica infantil y del adulto

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis seborreica: dermatosis eritematoescamosa crónica por respuesta anormal a Malassezia; escamas grasosas, untuosas y amarillentas en zonas seborreicas: cuero cabelludo (caspa), surcos nasogenianos, cejas, entrecejo, retroauricular y región esternal. Prurito leve.

- Lactante: costra láctea y eritema en cuero cabelludo y zona interciliar; benigna y autolimitada, en un niño de buen aspecto y con buena ganancia de peso.
- Tratamiento del adulto: champú de ketoconazol 2 % o sulfuro de selenio 2–3 veces por semana, ketoconazol crema en cara, y corticoide tópico de baja potencia en ciclos cortos para el brote inflamatorio.
- Tratamiento del lactante: no requiere antimicóticos; vaselina o aceite para ablandar y retirar las escamas, champú suave.
- Bandera roja: forma severa, extensa y refractaria en adulto joven obliga a pedir VIH; también más grave en Parkinson. Seguimiento completo: es crónica y recidivante, se controlan las recaídas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años consulta por descamación y enrojecimiento facial de 1 año, que empeora en invierno y en períodos de estrés. Al examen hay placas eritematosas mal delimitadas cubiertas por escamas amarillentas de aspecto oleoso en los surcos nasogenianos, las cejas y la región retroauricular, además de caspa en el cuero cabelludo. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A) Terbinafina oral por 6 semanas
B) Isotretinoína oral
C) Ketoconazol al 2% tópico en crema y champú
D) Prednisona oral en dosis bajas por 1 mes
E) Peróxido de benzoílo en gel

Respuesta C. Escamas amarillentas oleosas en zonas seborreicas, como surcos nasogenianos, cejas, retroauricular y cuero cabelludo, con brotes por frío y estrés, son una dermatitis seborreica del adulto. La base del tratamiento son los antifúngicos tópicos contra Malassezia, como ketoconazol en crema y champú; los corticoides tópicos de baja potencia solo en ciclos cortos.

6.01.1.007 Dermitis de contacto

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Irritativa (80 %): daño tóxico directo sin sensibilización previa (detergentes, agua y jabón, solventes: «eccema de dueñas de casa»); ardor y tirantez, lesión confinada al área de contacto con bordes netos, piel fisurada. Parche negativo.
- Alérgica (20 %): hipersensibilidad retardada tipo IV; requiere sensibilización previa. Prurito intenso, eccema con vesículas que sobrepasan el área de contacto. Níquel (bisutería, hebillas, botones, piercings) es el alérgeno más frecuente; cromo en cemento húmedo.
- Confirmación de la alérgica: pruebas epicutáneas (patch test) con lecturas a las 48 y 96 horas.
- Tratamiento completo: identificar y evitar el agente, guantes con forro de algodón y cremas barrera (irritativa); corticoide tópico de mediana-alta potencia (cara y pliegues baja potencia) en brote agudo, compresas frías en lesiones exudativas, antihistamínico para el prurito.
- Seguimiento completo: controlar recidiva y educación laboral; derivar si es crónica, ocupacional o sin causa identificada para patch test.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 144

Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings hace una semana. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Celulitis
B) Erisipela
C) Dermatitis de contacto alérgica
D) Dermatitis de contacto irritativa
E) Piodermitis superficial

Respuesta C. Lesión que aparece tras un piercing y se extiende más allá de la zona del aro, hacia el cuello, orienta a una dermatitis de contacto alérgica al níquel del piercing, que sobrepasa el área de contacto. La celulitis no se explica sin tejido celular subcutáneo en la oreja.

6.01.1.008 Enfermedades de transmisión sexual

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

QUÉ HAY QUE SABER

- Sífilis (Treponema pallidum): primaria = chancro único, indurado, indoloro, de fondo limpio con adenopatía regional indolora (cura sola en 3–6 semanas); secundaria = roséola maculopapular que compromete palmas y plantas, condilomas planos perianales y poliadenopatías; latente (precoz <1 año, tardía >1 año o desconocida); terciaria = gomas, aortitis, neurosífilis.
- Serología: VDRL/RPR (no treponémica, cuantitativa) mide actividad y respuesta (curación = caída de 4 veces a los 6–12 meses); MHA-TP/FTA-ABS (treponémicas) confirman y quedan positivas de por vida. VDRL bajo con treponémica negativa = falso positivo biológico (LES, embarazo): no tratar; si hay chancro y serología negativa, repetir en ~3 semanas.
- Tratamiento de sífilis: penicilina benzatina 2.400.000 UI IM dosis única si es precoz; 1 dosis semanal por 3 semanas si es tardía o de duración desconocida. Reacción de Jarisch-Herxheimer benigna (paracetamol). Embarazada alérgica: desensibilizar y tratar con penicilina (doxiciclina contraindicada). Estudiar VIH y tratar contactos de los últimos 90 días.
- Uretritis/cervicitis: doble cobertura siempre, ceftriaxona 500 mg IM dosis única (gonococo) más doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 7 días o azitromicina 1 g (clamidia). Herpes genital: aciclovir 400 mg cada 8 horas por 7–10 días. Chancroide: azitromicina 1 g o ceftriaxona 250 mg IM. Condilomas acuminados: podofilotoxina 0,5 %, imiquimod 5 % o crioterapia.
- Seguimiento completo: control serológico con VDRL cuantitativo, consejería, estudio de otras ITS (VIH, hepatitis B) y notificación obligatoria; contactos sexuales tratados.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 28 años consulta por lesiones en palmas y plantas de 2 semanas, no pruriginosas. Al examen se observan máculas y pápulas eritemato-cobrizas descamativas en palmas y plantas, placas blanquecinas en la mucosa oral y adenopatías generalizadas. Refiere una úlcera genital indolora que desapareció sola hace 2 meses. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de elección?**

A) Eritema multiforme; antihistamínicos
B) Pitiriasis rosada; observación
C) Psoriasis palmoplantar; corticoide tópico
D) Sífilis secundaria; penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular dosis única
E) Sífilis terciaria; penicilina sódica endovenosa por 14 días

Respuesta D. Exantema de palmas y plantas cobrizo, lesiones mucosas y adenopatías tras un chancro indoloro autolimitado es sífilis secundaria. Se confirma con VDRL o RPR y prueba treponémica (MHA-TP), y se trata con penicilina benzatina 2,4 millones UI IM dosis única. Debe estudiarse VIH y notificar y tratar contactos.

6.01.1.009 Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.1 Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

QUÉ HAY QUE SABER

- Eritema nodoso: paniculitis septal reactiva; nódulos dolorosos, calientes y eritemato-violáceos de 2–5 cm en la cara anterior de ambas piernas, a veces con fiebre y artralgias; no se ulceran y curan sin cicatriz (cambian de color como un hematoma). Más frecuente en mujeres jóvenes.
- Causas: infección estreptocócica (faringitis), fármacos (anticonceptivos orales, sulfas), sarcoidosis, tuberculosis, enfermedad inflamatoria intestinal, embarazo y otras; en muchos casos es idiopático.
- Eritema indurado de Bazin: paniculitis lobulillar en pantorrillas de mujeres jóvenes, crónica y recurrente, que tiende a ulcerarse; asociado a tuberculosis (buscar PPD/IGRA). Diferenciar de trombosis venosa superficial, celulitis y vasculitis.
- Sospecha y estudio inicial: ASO o cultivo faríngeo, radiografía de tórax, PPD, hemograma/VHS y embarazo; biopsia profunda si es atípico. Tratamiento inicial: reposo con piernas elevadas, AINE, tratar la causa y suspender fármacos.

- Seguimiento: derivar a dermatología o medicina interna para estudio etiológico y manejo de Bazin, recurrencias o falta de causa; el eritema nodoso habitualmente se resuelve en 3–6 semanas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 25 años consulta por nódulos dolorosos, eritemato-violáceos, calientes, de 2 a 4 cm, en la cara anterior de ambas piernas, de 1 semana. No se ulceran. Refiere odinofagia hace 3 semanas. Usa anticonceptivos orales. **¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial más adecuado?**

A) Eritema indurado de Bazin; biopsia y PPD
B) Trombosis venosa superficial; ecografía Doppler
C) Vasculitis leucocitoclástica; biopsia urgente
D) Celulitis bilateral; antibióticos endovenosos
E) Eritema nodoso; estudio etiológico con ASO o cultivo faríngeo, radiografía de tórax y PPD

Respuesta E. El eritema nodoso es una paniculitis septal reactiva: nódulos dolorosos en cara anterior de piernas que no se ulceran y curan sin cicatriz. Causas: estreptococo, fármacos (anticonceptivos), sarcoidosis, TBC, EII. Se busca la causa (ASO, radiografía de tórax, PPD). El eritema indurado de Bazin es lobulillar, en pantorrillas y tiende a ulcerarse.

6.01.1.010 Eritema polimorfo menor

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.12 Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

QUÉ HAY QUE SABER

- Eritema polimorfo (multiforme) menor: lesiones en diana típicas de 3 anillos (centro oscuro o ampolla, anillo pálido edematoso, halo rojo) de distribución acral y simétrica (manos, antebrazos, codos, rodillas). Mucosa ausente o una sola, sin fiebre, Nikolsky negativo.
- Causa: infecciosa en >90 %: virus herpes simple (>70 %, herpes labial 1–2 semanas antes) y Mycoplasma pneumoniae (niños); los fármacos son poco frecuentes. Se diferencia de SSJ por dianas de 3 anillos, distribución acral y ausencia de desprendimiento.
- Tratamiento inicial: autolimitado (2–4 semanas); sintomático con antihistamínico oral y corticoide tópico; enjuagues antisépticos o lidocaína viscosa si hay dolor oral. Aciclovir oral si el herpes está activo.
- Recurrente (3–5 brotes al año por VHS): aciclovir profiláctico continuo 400 mg cada 12 horas por 6 meses. Tratar Mycoplasma con macrólido si corresponde.
- Seguimiento completo por médico general; derivar formas major (≥2 mucosas con fiebre) o duda con SSJ.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 26 años consulta por lesiones cutáneas de 2 días de evolución en el dorso de ambas manos y los codos, redondeadas, de 1 a 2 cm, con un centro violáceo, un anillo pálido y un halo rojo bien delimitado. Refiere un episodio de herpes labial hace 9 días, ya en fase de costra. No tiene fiebre, y la mucosa oral está indemne. El signo de Nikolsky es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalizar de inmediato por sospecha de Stevens-Johnson
B) Manejo ambulatorio con antihistamínico oral y corticoide tópico
C) Biopsia cutánea urgente con inmunofluorescencia directa
D) Prednisona oral en dosis altas por 2 a 3 meses
E) Traslado a Centro de Quemados por riesgo de desprendimiento

Respuesta B. Dianas de 3 anillos, distribución acral, antecedente de herpes labial 9 días antes, sin fiebre, sin mucosas comprometidas y Nikolsky negativo: eritema multiforme minor. El manejo es ambulatorio y sintomático; no hay indicación de hospitalización, biopsia urgente ni corticoides sistémicos.

Pregunta de práctica

Un adulto joven de 24 años consulta por lesiones redondeadas eritematosas en el dorso de ambas manos y antebrazos, con un centro purpúrico violáceo rodeado por un anillo pálido edematoso y un halo eritematoso externo. Refiere un episodio de herpes labial hace una semana. No se palpan adenopatías y el signo de Nikolsky es negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el agente causal más frecuentemente asociado?**

A) Síndrome de Stevens-Johnson por ingesta de paracetamol
B) Eritema multiforme por infección por Virus Herpes Simple
C) Urticaria multiforme por virus de Epstein-Barr
D) Penfigoide ampollar por exposición a radiación UV
E) Lupus eritematoso discoide por fotosensibilidad

Respuesta B. Lesiones en diana de 3 anillos en zonas acrales, con Nikolsky negativo y antecedente de herpes labial 7 a 14 días antes: eritema multiforme por virus herpes simple, la causa de más del 70% de los casos. SSJ tendría Nikolsky positivo y dianas atípicas de 2 anillos.

6.01.1.011 Fotodermatosis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Fotodermatosis: lesiones en zonas fotoexpuestas (cara, escote, dorso de manos y antebrazos) tras exposición solar; sospechar con tiempo de latencia desde el sol y distribución en áreas expuestas.
- Tipos frecuentes: erupción polimorfa solar (pápulas/placas pruriginosas horas–días después del sol), urticaria solar (habones minutos tras el sol), fototoxia y fotoalergia por fármacos o plantas, fitofotodermatitis (furocumarinas de plantas + UV: lesiones lineales o caprichosas, luego hiperpigmentadas).
- Fármacos fotosensibilizantes frecuentes: tetraciclinas, tiazidas, AINE, amiodarona, quinolonas; considerar lupus cutáneo y porfirias si hay compromiso sistémico o cicatrices.
- Tratamiento inicial: suspender el agente, evitar el sol, fotoprotección FPS ≥50 de amplio espectro, corticoide tópico en lesiones agudas y antihistamínico oral para el prurito.
- Seguimiento completo con fotoprotección permanente; derivar a dermatología si es recurrente, grave o se sospecha lupus/porfiria.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 115

Paciente de 25 años consulta por lesiones en las extremidades inferiores. Refiere que ayer estuvo jugando fútbol al aire libre y que las lesiones empezaron a aparecer después. Hace 1 año le pasó algo similar luego de andar en moto por los cerros. Al examen físico se observan, en ambos muslos y piernas, múltiples lesiones eritemato-violáceas, muchas con disposición lineal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Fitodermatitis
B) Enfermedad ampollar
C) Urticaria solar
D) Lupus discoide
E) Vasculitis leucocitoclástica

Respuesta A. Lesiones eritematosas o hiperpigmentadas de disposición lineal o caprichosa en zonas expuestas, tras contacto con plantas al aire libre y exposición solar, son una fitofotodermatitis (furocumarinas más luz UV). Se maneja con evitar el contacto, fotoprotección y corticoide tópico. La urticaria solar da habones fugaces minutos después del sol.

6.01.1.012 Granuloma piogénico

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.8 Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Granuloma piógeno (hemangioma capilar lobulillar): pápula o nódulo exofítico rojo brillante, friable, de superficie lisa y húmeda, con collarete, de crecimiento rápido en semanas, que sangra con facilidad; en dedos, cara y mucosa oral (encías en embarazadas).
- Se asocia a traumatismo menor, embarazo (segundo-tercer trimestre) y fármacos (retinoides, anticonceptivos); es benigno, no purulento ni granulomatoso.

- Diferencial importante: melanoma amelanótico, carcinoma espinocelular, sarcoma de Kaposi, verruga: por eso siempre se envía la pieza a histología.
- Tratamiento completo: exéresis con curetaje y electrocoagulación de la base (o exéresis con sutura), con estudio histológico; también nitrato de plata o láser en lesiones pequeñas. Controlar el sangrado con presión.
- Seguimiento completo: la recurrencia es frecuente si queda tejido residual; en embarazadas se puede diferir hasta el posparto si es asintomático.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 62

Paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por una lesión cutánea en el dedo medio de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen se observa una pápula exofítica rojo brillante, de superficie lisa y húmeda, pediculada, con collarete descamativo en la base. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Verruga vulgar
B) Granuloma piógeno
C) Molusco contagioso
D) Melanoma amelanótico
E) Carcinoma basocelular

Respuesta B. Una lesión vascular roja, friable, de crecimiento rápido y sangrado fácil, con collarete, en dedos, en una embarazada, es un granuloma piógeno (hemangioma capilar lobulillar). Se trata con exéresis o curetaje con electrocoagulación y estudio histológico, para descartar un melanoma amelanótico. En el embarazo puede regresar después del parto.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 31 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por aparición de una lesión cutánea en el dedo medio, de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen físico, se observa la siguiente fotografía (fuente: sanchezcarpinterodermatologo.blogspot.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Verruga vulgar
B) Granuloma piógeno
C) Molusco contagioso
D) Melanoma amelanótico
E) Carcinoma basocelular

Respuesta B. Diagnóstico: Granuloma piógeno (opción B). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

Un adolescente de 14 años consulta por una lesión de color rojo, en el tórax, que apareció hace algunas semanas y que ha sangrado varias veces, en relación al roce de la ropa. Se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pioderma gangrenoso
B) Hemangioma infantil
C) Nevo atípico inflamatorio
D) Granuloma telangiectásico
E) Melanoma maligno

Respuesta D. Diagnóstico: Granuloma telangiectásico (opción D). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

6.01.1.013 Hemangiomas cutáneos infantiles

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: derma-17

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemangioma infantil: tumor vascular benigno más frecuente de la infancia; aparece en las primeras semanas de vida como mácula pálida o telangiectasias y luego crece (fase proliferativa hasta 6–12 meses) y involuciona lentamente (hasta los 5–10 años).
- Específico: placa o nódulo rojo brillante («fresa»), superficial, profundo (azulado) o mixto; más frecuente en prematuros, niñas y raza blanca; marcador GLUT-1 positivo. Diferenciar de malformaciones vasculares (presentes al nacer, no involucionan).

- Tratamiento inicial: la mayoría solo observación y control fotográfico. Indicación de tratamiento precoz (propranolol oral 1–3 mg/kg/día por especialista): compromiso periocular o de vía aérea, ulceración, localización de la nariz, labios o región perineal, multifocal (≥5 lesiones) o desfigurante.
- Alerta: hemangioma periocular riesgo de ambliopía; segmentarios de cara se asocian a síndrome PHACE; ≥5 hemangiomas cutáneos obligan a buscar compromiso hepático; segmentario lumbosacro a disrafismo.
- Seguimiento: derivar a dermatología pediátrica (o cirugía infantil/oftalmología según localización) en lactantes con riesgo funcional o rápido crecimiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 125

Lactante de 6 meses presenta 8 hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. **¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?**

A) Solicitar ecografía abdominal
B) Iniciar propranolol oral
C) Iniciar corticoides intralesionales
D) Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro
E) Solicitar estudio de neurofibromatosis

Respuesta A. Cinco o más hemangiomas cutáneos se asocian a hemangiomas hepáticos, que pueden causar insuficiencia cardíaca o hipotiroidismo, por lo que se indica ecografía abdominal. El propranolol se indica según localización, tamaño o complicación de las lesiones, no por su número. La resonancia cerebral se piensa en hemangiomas segmentarios faciales (PHACE).

6.01.1.014 Linfomas cutáneos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Linfomas cutáneos: neoplasias de células T (micosis fungoide, 65 %) o B primarias de la piel. Micosis fungoide: curso lento, mácula o placa eritematosa descamativa, bien delimitada, poiquilodermia, en zonas no expuestas («traje de baño»), que se confunde por años con eccema o psoriasis.
- Sospecha: lesiones de «eccema» o psoriasis crónicas, atípicas, que no responden a corticoides tópicos, con prurito persistente; progresan a placas infiltradas, tumores y eritrodermia.
- Síndrome de Sézary: eritrodermia pruriginosa, adenopatías y células de Sézary circulantes (forma leucémica); queratodermia palmoplantar y onicodistrofia.
- Tratamiento inicial: derivar con biopsia cutánea múltiple e inmunohistoquímica; en etapas precoces corticoides tópicos potentes y fototerapia (PUVA/UVB) por especialista, evitando retrasos por diagnóstico erróneo.
- Seguimiento: derivar a dermatología/hematología para estadificación (TNMB), tratamiento sistémico y control periódico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 113

Paciente con prurito intenso, eritema y descamación difusos de la piel incluyendo ambas manos, que se ven eritematosas y descamativas, engrosamiento de las uñas de manos y pies, y aumento de volumen inguinal bilateral por adenopatías. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Linfoma cutáneo (síndrome de Sézary)
B) Sarna noruega
C) Psoriasis
D) Dermatitis crónica
E) Dermatitis atópica

Respuesta A. La tríada de eritrodermia pruriginosa, adenopatías y células de Sézary (linfocitos T atípicos) circulantes define el síndrome de Sézary, la forma leucémica del linfoma T cutáneo (relacionado con micosis fungoide). Se acompaña de queratodermia palmoplantar y onicodistrofia. Se confirma con biopsia de piel, frotis y citometría de flujo.

6.01.1.015 Líquen plano

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.5 Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Líquen plano: pápulas planas, poligonales, violáceas y muy pruriginosas (las «6 P») en cara flexora de muñecas, tobillos y región lumbar; estrías de Wickham en superficie. Fenómeno de Koebner positivo.
- Mucosa oral: retículo blanquecino en mucosa yugal; puede haber compromiso ungueal (pterigión), genital y cuero cabelludo (alopecia cicatricial).
- Se asocia a hepatitis C (solicitar serología VHC), fármacos (tiazidas, IECA, antimaláricos) y enfermedades autoinmunes. Diferencial con psoriasis (placas con escama plateada) y liquen simple crónico.
- Tratamiento inicial: corticoide tópico de alta potencia (clobetasol) 2 veces al día + antihistamínico oral para el prurito; en lesión oral, corticoide tópico en orabase.
- Seguimiento: derivar a dermatología si es extenso, ungueal, de cuero cabelludo o no responde; el liquen oral erosivo requiere control periódico por riesgo de carcinoma escamoso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años con pápulas planas, poligonales, violáceas y muy pruriginosas en la cara flexora de muñecas y tobillos, de 2 meses. En su superficie se observan finas estrías blanquecinas. Aparecieron nuevas lesiones sobre una excoriación lineal. En la mucosa yugal tiene un retículo blanquecino. **¿Cuál es el diagnóstico y qué examen de laboratorio conviene solicitar?**

A) Liquen plano; serología de virus hepatitis C
B) Psoriasis; perfil lipídico
C) Pitiriasis rosada; VDRL
D) Lupus discoide; ANA
E) Prurigo nodular; IgE total

Respuesta A. Pápulas planas, poligonales, púrpuras, pruriginosas con estrías de Wickham, fenómeno de Koebner y lesiones reticuladas en mucosa oral son liquen plano (las 6 P). Se asocia a hepatitis C, por lo que se solicita su serología. Se trata con corticoides tópicos potentes; el liquen plano oral erosivo crónico requiere seguimiento por riesgo de carcinoma.

6.01.1.016 Lupus eritematoso cutáneo crónico (lupus discoide)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.10 Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas

QUÉ HAY QUE SABER

- Lupus eritematoso cutáneo crónico (discoide): placas eritematosas bien delimitadas con escama adherente y tapones córneos foliculares, borde activo con telangiectasias y atrofia central con cicatriz y despigmentación; en cara (mejillas, nariz), orejas y cuero cabelludo.
- En cuero cabelludo causa alopecia cicatricial irreversible (sin orificios foliculares). Fotosensible; ANA habitualmente negativos o en título bajo; <10 % evoluciona a lupus sistémico. Diferencial: lupus subagudo (lesiones anulares policíclicas sin cicatriz; anti-Ro), rosácea, psoriasis, liquen plano, sarcoidosis.
- Sospecha y confirmación: biopsia cutánea con inmunofluorescencia (banda lúpica) y ANA/anti-ENA para descartar compromiso sistémico.
- Tratamiento inicial: fotoprotección estricta (FPS ≥50), evitar tabaco, corticoide tópico potente o tacrolimus; hidroxicloroquina oral (≤5 mg/kg/día) en lesiones extensas o de cuero cabelludo (control oftalmológico).
- Seguimiento: derivar a dermatología/reumatología; el tratamiento precoz evita cicatrices y alopecia definitiva.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 14

Mujer de 35 años con placas eritematosas en cuero cabelludo con alopecia cicatricial, fotosensibilidad y presencia de tapones foliculares. Presenta lesiones similares en las mejillas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tinea capitis
B) Alopecia androgénica
C) Tricotilomanía
D) Lupus eritematoso discoide
E) Alopecia areata

Respuesta D. Placas eritematosas con escamas adherentes, tapones foliculares y alopecia cicatricial en zonas fotoexpuestas definen el lupus discoide, la forma cutánea crónica. Solo una minoría evoluciona a lupus sistémico. Se trata con fotoprotección, corticoides tópicos y antimaláricos. La alopecia areata no deja cicatriz.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 2 · texto original del banco, sin revisar

Mujer 30 años con aparición de Placa eritematodescamativa de 2 meses de evolución en pómulo derecho de 3 cm de diámetro y otra similar en cuero cabelludo (zona parietal izquierda) con alopecia central.

A) Lupus cutáneo crónico
B) Dermatitis seborreica
C) Psoriasis
D) Liquen plano
E) Rosácea

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Lupus cutáneo crónico). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Dermatitis seborreica, Psoriasis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

6.01.1.017 Melanoma maligno

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.13 Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en lesión pigmentada con ABCDE (Asimetría, Bordes irregulares, Color heterogéneo, Diámetro >6 mm, Evolución); la evolución (cambio, lesión nueva, «patito feo») es el criterio más sensible. Riesgo: fototipo claro, quemaduras solares en la infancia, >50–100 nevos, nevos displásicos, antecedente familiar (CDKN2A).
- Subtipos: extensión superficial (~70 %), nodular (15 %, el más agresivo, nódulo azul-negro), léntigo maligno melanoma (cara de ancianos), lentiginoso acral (palmas, plantas y uñas; el más frecuente en población mestiza chilena y no depende del sol).
- Manejo inicial: la dermatoscopía apoya pero no reemplaza a la biopsia; biopsia excisional completa con margen de 1–2 mm y tejido subcutáneo para medir el Breslow real. Shave y punch superficial están contraindicados (subestiman el espesor).
- El Breslow define el pronóstico y el tratamiento: margen definitivo in situ 0,5 cm, hasta 1 mm 1 cm, 1–2 mm 1–2 cm, >2 mm 2 cm; ganglio centinela si >0,8 mm o con ulceración. Enfermedad avanzada: inmunoterapia anti-PD-1 e inhibidores BRAF/MEK si hay mutación.
- Seguimiento: derivar a dermatología/oncología de forma preferente (garantía de oportunidad) ante sospecha; el médico general no hace la ampliación.

PREGUNTAS (4)

Pregunta de práctica

Un hombre de 46 años consulta por un nevo en la espalda que ha cambiado de color y aumentado de tamaño en los últimos 4 meses. Al examen se observa una lesión macular asimétrica de 8 mm con bordes irregulares y tres colores distintos (café claro, negro y grisáceo). **¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección?**

A) Cauterización con nitrógeno líquido (crioterapia) en la consulta
B) Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen lateral y celular subcutáneo
C) Biopsia por afeitado (shave) superficial para no dejar cicatriz antiestética
D) Biopsia por sacabocados (punch) de 2 mm tomada del centro más pigmentado de la lesión
E) Control fotográfico digital seriado cada 3 meses

Respuesta B. Ante una lesión con sospecha clínica de melanoma maligno, el estándar de oro diagnóstico es la biopsia excisional completa con márgenes estrechos de 1 a 2 mm y en toda la profundidad del tejido celular subcutáneo, lo que permite medir el espesor de Breslow sin desestructurar la lesión.

Pregunta de práctica

Mujer de 50 años, sin metástasis demostradas, recibe el informe de la biopsia excisional de una lesión pigmentada del dorso que confirma un melanoma de extensión superficial. **¿Cuál es el factor pronóstico más importante en este melanoma localizado?**

A) El diámetro de la lesión en la superficie
B) El número de colores de la lesión
C) El espesor tumoral de Breslow
D) La edad de la paciente
E) El tiempo de evolución referido por la paciente

Respuesta C. En el melanoma localizado, el factor pronóstico más importante es el espesor de Breslow, medido en milímetros desde la capa granular hasta la célula tumoral más profunda. Define el estadio, los márgenes de ampliación y la indicación de biopsia de ganglio centinela. La ulceración es el segundo factor relevante.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 178 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 26 años nota aparición de una lesión en el tercio medio de la pierna derecha, desde hace 6 meses, con crecimiento progresivo. Al examen físico se observa lo siguiente: Fuente: www.alamy.com El diagnóstico más probable es:

A) Nevo
B) Melanoma
C) Léntigo
D) Queratosis seborreica
E) Queratosis actínica

Respuesta B. Es un melanoma clásico, tanto por la edad, como por el crecimiento. La imagen sí tiene un aspecto de queratosis seborreica, aunque el halo hiperpigmentado y la lesión satélite son más de melanoma.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 115 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 90 años con 3 lesiones pigmentadas de crecimiento progresivo en la pierna. La mayor se muestra en imagen. ¿Diagnóstico más probable?

A) Queratosis seborreica pigmentada
B) Melanoma con satelitosis
C) Carcinoma basocelular pigmentado
D) Nevo melanocítico displásico
E) Dermatofibroma pigmentado

Respuesta B. Diagnóstico: Melanoma con satelitosis (opción B). Melanoma con satelitosis. El melanoma maligno es el tumor maligno de piel más mortal aunque no el más frecuente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

6.01.1.018 Micosis superficiales

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatofitosis (tiñas): hongos filamentosos que digieren queratina. Tiña del cuerpo: placa anular con borde activo solevantado, descamativo o con vesículas y centro que aclara. Tiña inguinal: placa bilateral en pliegues

que respeta el escroto (si lo toma con lesiones satélites es candidiasis). Tiña del pie: maceración interdigital (cuarto espacio) o patrón en mocasín.

- Pitiriasis versicolor (Malassezia): máculas hipo o hiperpigmentadas en tronco y cuello con descamación fina al raspar (signo de la uñada); KOH muestra «albóndigas con espaguetis».
- Confirmación: examen micológico directo (KOH) y cultivo de escamas del borde activo, útil sobre todo en uñas y cuero cabelludo; no usar corticoide tópico (empeora y enmascara la tiña, «tiña incógnita»).
- Tratamiento completo: lesiones cutáneas localizadas con antifúngico tópico (terbinafina o clotrimazol 2–4 semanas); pitiriasis versicolor con ketoconazol 2 % champú/crema o terbinafina tópica. Tiña de la cabeza (niños, pelos «en sacapuntas», querion) siempre oral: griseofulvina 20–25 mg/kg/día por 6–8 semanas con comida grasa o terbinafina. Onicomicosis confirmada: terbinafina oral (12 semanas en pies).
- Seguimiento completo: control de la respuesta, tratar fuentes (mascotas, calzado) y derivar formas extensas, recurrentes o refractarias.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 44

Un paciente de 40 años consulta por hiperqueratosis y cambio de coloración de las uñas de los ortejos, de algunos meses de evolución. Se realiza estudio micológico, que muestra presencia de Trichophyton rubrum. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Itraconazol
B) Griseofulvina
C) Fluconazol
D) Terbinafina
E) Clotrimazol

Respuesta D. La onicomicosis por dermatofitos, como Trichophyton rubrum, se trata de elección con terbinafina oral, por alrededor de 12 semanas en las uñas de los pies, tras confirmar con estudio micológico. El clotrimazol tópico no penetra la lámina ungueal y la griseofulvina es menos eficaz.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 20 · texto original del banco, sin revisar

Un escolar de 7 años consulta por una zona alopécica de 2 semanas de evolución, que ha ido en creciendo. Al examen físico se aprecia la placa alopécica de 4 cm, con des- camación y pelos entrecortados, tal como se muestra en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tiña capitis
B) Tricotilomanía
C) Alopecia areata
D) Lupus discoide
E) Dermatitis solar

Respuesta A. Diagnóstico: Tiña capitis (opción A). Tiña capitis clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 85 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 50 años, diabética, con antecedente de insuficiencia renal e hígado graso, consulta por lesiones pruriginosas y eritematosas debajo de las mamas, en la región inguinal y debajo del abdomen. El tratamiento más adecuado es:

A) Mupirocina tópica
B) Cefadroxilo oral
C) Griseofulvina oral
D) Fluconazol oral
E) Ketoconazol tópico

Respuesta E. Tiene un intétrigo candidiásico. Por el antecedente de IRC y hepatopatía, se prefieren los antimicóticos tópicos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 176 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 70 años, diabética en tratamiento farmacológico y con obesidad, consulta por lesiones en el tórax, asociadas a prurito. Al examen físico de pliegues mamarios se encuentran lesiones eritematosas asociadas a rezumación con pequeñas pústulas blancas. El diagnóstico más probable es:

A) Acrocordones
B) Intértrigo candidiásico
C) Impétigo buloso
D) Tiña corporis
E) Psoriasis

Respuesta B. Diagnóstico: Intértrigo candidiásico (opción B). Es un intértrigo: infección por hongos en los pliegues. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

6.01.1.019 Pediculosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Pediculosis capitis (Pediculus humanus capitis): prurito del cuero cabelludo, sobre todo en la nuca y detrás de las orejas, en escolares; se contagia por contacto directo, peinetas y gorros.
- Diagnóstico: visualizar piojos vivos o liendres firmemente adheridas al tallo del pelo a menos de 1–3 cm del cuero cabelludo (indican infestación activa aunque no se vean piojos adultos); excoriaciones y adenopatías occipitales.
- Tratamiento: permetrina al 1 % en loción o champú (no 5 %, que es para sarna) en el cuero cabelludo, repetida a los 7–10 días porque no es completamente ovicida; remoción mecánica de liendres con peineta fina.
- Alternativas en resistencia: dimeticona o ivermectina oral (casos resistentes). Tratar a los convivientes afectados, lavar ropa de cama y peinetas con agua caliente (>60 °C) o aislar en bolsa cerrada.
- Seguimiento completo por médico general: reevaluar a los 7–10 días; si hay impétigo secundario tratar con antibiótico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 32 años, madre de dos escolares con pediculosis, consulta por prurito del cuero cabelludo de 2 semanas. Al examen se observan piojos vivos y liendres firmemente adheridas al tallo del pelo, cerca de la raíz, en la región occipital y retroauricular. No está embarazada. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Ivermectina oral como primera línea y rapado del cabello
B) Corticoide tópico y antihistamínico oral
C) Champú de ketoconazol por 4 semanas
D) Permetrina al 1% en loción aplicada en el cuero cabelludo, repetida a los 7 a 10 días, con retiro mecánico de liendres y tratamiento de los convivientes afectados
E) Lavado diario de cabello con agua y vinagre como única medida

Respuesta D. La pediculosis capitis se trata con pediculicida tópico, de elección permetrina al 1%, repitiendo a los 7 a 10 días porque no es completamente ovicida. Se agrega retiro de liendres con peineta fina, tratamiento simultáneo de los convivientes afectados y lavado de ropa de cama y peinetas.

6.01.1.020 Pénfigo

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.11 Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pénfigo vulgar: autoanticuerpos IgG anti-desmogleína 3 (mucosas) y 1 (piel) → acantolisis, ampolla intraepidérmica suprabasal; adultos de 40–60 años. Es potencialmente mortal.
- Sospecha: erosiones/úlceras orales dolorosas persistentes (primer síntoma en 70–90 %), luego ampollas flácidas sobre piel sana que se rompen y dejan erosiones sangrantes; Nikolsky positivo y Asboe-Hansen positivo.

- Diagnóstico por biopsia: histología con ampolla suprabasal («hilera de lápidas sepulcrales») e inmunofluorescencia directa con depósito intercelular de IgG y C3 en «red de pescar». Toma de muestra: ampolla reciente más piel perilesional.
- Tratamiento inicial: derivar con prednisona 1–1,5 mg/kg/día (con protección gástrica y de hueso); rituximab de primera línea según guías actuales; azatioprina o micofenolato como ahorradores de corticoides. Antes de los corticoides la mortalidad era >70 % (sepsis, deshidratación).
- Seguimiento: derivar a dermatología (hospitalizar si es extenso); control de efectos adversos de corticoides.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 52 años consulta por erosiones dolorosas en la mucosa yugal y encías de 2 meses de evolución, sin respuesta a antimicóticos. Hace 10 días notó ampollas de pared muy delgada en el tronco, que se rompen con el roce de la ropa dejando zonas denudadas dolorosas. Al frotar suavemente la piel sana cercana a una lesión, la epidermis se desprende con facilidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento inicial?**

A) Penfigoide ampollar; clobetasol tópico de alta potencia
B) Pénfigo vulgar; prednisona oral en dosis altas
C) Dermatitis herpetiforme; dapsona y dieta sin gluten
D) Necrólisis epidérmica tóxica; traslado a Centro de Quemados
E) Eritema multiforme major; aciclovir oral

Respuesta B. Úlceras orales dolorosas como debut, ampollas flácidas de pared delgada y Nikolsky positivo en una mujer de mediana edad: Pénfigo Vulgar. El tratamiento inicial es prednisona oral en dosis altas. El penfigoide es Nikolsky negativo y respeta la mucosa oral; no hay antecedente farmacológico ni fiebre para pensar en NET.

6.01.1.021 Piodermias superficiales y profundas (no linfáticas)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Piodermias superficiales: impétigo (costras melicéricas periorificiales en niños; S. aureus y S. pyogenes), foliculitis (pústula centrada en un vello; S. aureus; tras tinas calientes piensa en Pseudomonas, autolimitada). Profundas: forúnculo (nódulo doloroso con necrosis central o «clavo»), ántrax estafilocócico (forúnculos coalescentes en nuca/espalda de diabéticos), erisipela y celulitis.
- Impétigo localizado con pocas lesiones: mupirocina 2 % tópica 5–7 días y aseo; extenso o con síntomas: cefadroxilo o flucloxacilina/cloxacilina oral 7–10 días. Foliculitis leve: aseo con clorhexidina o mupirocina 2 %.
- Forúnculo y absceso: calor local e incisión y drenaje; antibiótico sistémico solo si hay celulitis circundante, signos sistémicos, inmunosupresión o localización de riesgo (cara). Sospecha de SAMR comunitario o recurrencias: cotrimoxazol forte o clindamicina y cultivo.
- Alérgicos a betalactámicos: clindamicina 300 mg cada 8 horas. Buscar y tratar puerta de entrada y factores (diabetes, tinea pedis, portación nasal).
- Seguimiento completo: control a las 48–72 horas; derivar ántrax, infección facial, falla de tratamiento o recurrencias múltiples.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 55

Un paciente de 21 años consulta por aparición de lesiones cutáneas en la zona glútea de 6 días de evolución, consistentes en pápulas y pústulas, que están en estrecha relación con los folículos pilosos. **¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?**

A) Flucloxacilina
B) Ceftriaxona
C) Doxiciclina
D) Amoxicilina
E) Azitromicina

Respuesta A. Pápulas y pústulas centradas en folículos: foliculitis por Staphylococcus aureus. Entre las opciones, el único antiestafilocócico de elección es la flucloxacilina (también cloxacilina o cefadroxilo; clindamicina en alérgicos). En la foliculitis leve y localizada basta el aseo con clorhexidina o la mupirocina tópica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 111

Niño de 7 años con 3 lesiones eritematosas con costra melicérica en el abdomen, pruriginosas, sin fiebre. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Mupirocina tópica al 2%
B) Amoxicilina oral 7 días
C) Cefadroxilo oral 10 días
D) Clindamicina oral
E) Peróxido de benzoilo tópico

Respuesta A. Costras color miel sobre base eritematosa son un impétigo no ampollar (S. aureus o S. pyogenes). Con pocas lesiones, localizado y sin síntomas sistémicos, se trata con antibiótico tópico (mupirocina o ácido fusídico) por 5 a 7 días y aseo. El tratamiento oral (cefadroxilo, cloxacilina) se reserva para lesiones extensas, ampollares o brotes.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 86 · texto original del banco, sin revisar

Un adolescente consulta por aparición de lesiones en zona nasogeniana, eritematosas, pruginosas, desde hace una semana. Al examen físico se aprecian costras mielicéricas en la zona descrita. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Amoxicilina más ácido clavulánico
B) Macrólidos
C) Betametasona
D) Cefoperazona
E) Ciprofloxacino

Respuesta A. Tiene un impétigo. Cloxacilina o cefadroxilo habrían sido de elección, pero la amoxicilina más ácido clavulánico cubren bien al S. Aureus y al S. Pyogenes, que son los agentes etiológicos.

6.01.1.022 Pitiriasis Rosada de Gilbert

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Pitiriasis rosada de Gilbert: exantema autolimitado de adolescentes y adultos jóvenes, probablemente por VHH-6/7. Comienza con una placa heraldo (ovalada, de 2–5 cm, rosada con collarete descamativo) en el tronco.
- 1–2 semanas después aparecen múltiples placas ovaladas menores con collarete, orientadas según las líneas de tensión de la piel (patrón «en árbol de Navidad» en la espalda); prurito leve o ausente; cara, palmas y plantas respetadas.
- Diferencial: tiña del cuerpo (KOH), sífilis secundaria (si hay lesiones palmoplantares o en mucosas: pedir VDRL), psoriasis en gotas, exantemas por fármacos.
- Tratamiento completo: autolimitada (resuelve en 6–8 semanas) y sin secuelas; sintomático con emolientes, antihistamínico oral y corticoide tópico de baja-mediana potencia si hay prurito.
- Seguimiento completo: tranquilizar, explicar curso benigno y controlar si persiste >3 meses o cambia el cuadro.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 121

Mujer de 18 años presenta una placa eritematosa levemente pruriginosa de 5 cm en la espalda, sin otros síntomas. Una semana después se agregan múltiples lesiones similares, de menor tamaño, en todo el tronco. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tiña
B) Lupus cutáneo subagudo
C) Sífilis secundaria
D) Pitiriasis versicolor
E) Pitiriasis rosada

Respuesta E. Una placa heraldo seguida en 1 a 2 semanas de placas ovaladas más pequeñas con collarete, orientadas según las líneas de tensión del tronco (en árbol de Navidad), es pitiriasis rosada de Gilbert, probablemente viral (VHH 6 y 7). Es autolimitada en 6 a 8 semanas; se trata sintomáticamente. Ante dudas o lesiones palmoplantares, solicitar VDRL.

6.01.1.023 Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Prúrigo infantil agudo (estrófulo): reacción de hipersensibilidad a picaduras de insectos (pulgas, mosquitos, chinches) en niños de 2–7 años, de curso estacional.
- Pápulas eritematosas pruriginosas con vesícula o costra central y excoriaciones, agrupadas («desayuno, almuerzo y cena», en líneas de 3) en zonas descubiertas: piernas, antebrazos, cara.
- Diferencial: escabiosis (prurito nocturno, convivientes, pliegues interdigitales, genitales), varicela (vesículas en distintos estadios), dermatitis atópica, impétigo.
- Tratamiento completo: antihistamínico oral, corticoide tópico de baja-mediana potencia en las lesiones, compresas frías y repelentes; control ambiental del vector (mascotas, colchones, desinsectación).
- Seguimiento completo: evitar rascado, tratar sobreinfección bacteriana (mupirocina o cefadroxilo) y educar en prevención de picaduras.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 4 años con lesiones muy pruriginosas de 1 semana, tras vacaciones en el campo. Al examen hay pápulas eritematosas con vesícula central y excoriaciones agrupadas en zonas descubiertas (piernas y antebrazos), algunas en línea de 3. Nadie más en la casa tiene prurito y no hay lesiones en pliegues interdigitales ni genitales. **¿Cuál es el diagnóstico y manejo más adecuado?**

A) Prúrigo agudo infantil por picadura de insectos; antihistamínico oral, corticoide tópico de baja o mediana potencia y control de insectos
B) Escabiosis; permetrina a toda la familia
C) Varicela; aciclovir
D) Impétigo; mupirocina
E) Dermatitis atópica; inmunomoduladores tópicos

Respuesta A. Pápulas seropápulas pruriginosas agrupadas en zonas expuestas, en brotes estacionales y en grupos de 3 (desayuno, almuerzo y cena), corresponden a prúrigo por picadura de insectos (pulgas, mosquitos), una reacción de hipersensibilidad. Se maneja con antihistamínicos, corticoide tópico, repelentes y control ambiental. La sarna afecta pliegues y a los convivientes.

6.01.1.024 Psoriasis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.5 Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Psoriasis: placas eritematosas bien delimitadas con escamas gruesas blanco-nacaradas en codos, rodillas, región lumbosacra y cuero cabelludo, bilaterales y simétricas. Uñas: pitting, mancha en gota de aceite, onicólisis.
- Confirmación clínica con raspado de Brocq: signo de la bujía → membrana de Duncan-Dulck → signo de Auspitz (rocío sangrante, patognomónico). Fenómeno de Koebner. Formas: en placas, en gotas (post-estreptocócica), invertida, pustulosa y eritrodérmica; artritis psoriásica (IFD, dactilitis, FR negativo).
- Tratamiento inicial según superficie: <10 % corticoide potente (clobetasol/betametasona) + calcipotriol (máx. 100 g/semana) y emolientes. >10 % o compromiso articular: derivar (GES psoriasis moderada-grave: fototerapia UVB banda angosta, metotrexato semanal + ácido fólico, biológicos tras descartar TBC latente).
- Regla de oro: NUNCA corticoides sistémicos (orales o IM) en psoriasis; su suspensión desencadena rebote pustuloso generalizado o eritrodermia. Acitretina: teratógena hasta 3 años tras suspender.
- Seguimiento completo: controles periódicos, evaluar comorbilidades (síndrome metabólico, artritis) y derivar formas graves, pustulosas o eritrodérmicas (hospitalizar).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 120

Mujer de 35 años con placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas de escamas plateadas en rodillas y codos, con fenómeno de Auspitz positivo. Compromete el 10% de la superficie corporal. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Psoriasis en placas
B) Dermatitis atópica
C) Dermatitis de contacto
D) Liquen plano
E) Micosis fungoide

Respuesta A. Placas eritematosas con escamas plateadas en superficies extensoras más fenómeno de Auspitz positivo (sangrado puntiforme al retirar la escama) es psoriasis en placas. Un compromiso del diez por ciento corresponde a psoriasis moderada.

Pregunta de práctica

Hombre de 42 años consulta por placas eritematosas pruriginosas en ambos codos, región sacra y cuero cabelludo desde hace 2 años. Al examen físico se aprecian placas solevantadas de 4 a 6 cm de diámetro, bien delimitadas, cubiertas por escamas gruesas blanco-nacaradas. Al raspar con un abatelenguas, se desprenden virutas blanquecinas, luego una membrana transparente continua, y finalmente aparece un punteado hemorrágico fino en gotitas sobre la superficie desnudada. El compromiso estimado de superficie corporal es del ocho por ciento. **¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más adecuada?**

A) Prednisona oral en dosis decreciente por 2 semanas
B) Corticoide tópico de alta potencia combinado con calcipotriol
C) Metotrexato oral semanal más ácido fólico
D) Anticuerpo monoclonal anti-interleucina 17
E) Antibiótico oral de amplio espectro por 10 días

Respuesta B. El raspado metódico de Brocq con signo de Auspitz confirma psoriasis vulgar en placas. Con un compromiso del ocho por ciento de superficie corporal, es psoriasis leve, cuya primera línea es la terapia tópica combinada de corticoide potente más calcipotriol. El metotrexato y los biológicos son para formas moderadas a graves; el antibiótico es para la forma guttata; y la prednisona oral está formalmente contraindicada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 88 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, consulta por aparición de placas eritematodescamativas en las rodillas y los codos. El diagnóstico más probable es:

A) Dermatittis de contacto
B) Psoriasis vulgar
C) Tiña corporis
D) Pitiriasis rosada de Gibert
E) Dermatitis atópica

Respuesta B. Diagnóstico: Psoriasis vulgar (opción B). Cuadro clásico. La psoriasis vulgar es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen autoinmune que afecta aproximadamente al dos por ciento de la población mundial. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

6.01.1.025 Reacciones cutáneas por drogas (rush, toxidermia fija)

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.10 Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Exantema morbiliforme (rush) por fármacos: máculas y pápulas confluentes pruriginosas en tronco que se extienden a extremidades, 1–2 semanas después de iniciar el fármaco (antibióticos, AINE, anticonvulsivantes); sin fiebre alta, mucosas ni ampollas.
- Toxidermia fija (eritema pigmentado fijo): placa redonda eritematoviolácea, con ardor, que reaparece siempre en el mismo sitio horas después de reexponerse al mismo fármaco (AINE, cotrimoxazol, tetraciclinas) y deja mancha café grisácea residual.
- Específico: diagnóstico clínico con cronología fármaco–lesión; la reexposición confirma. Buscar banderas rojas de gravedad (fiebre alta, edema facial, dolor cutáneo, ampollas, Nikolsky positivo, compromiso de mucosas, eosinofilia o transaminasas) que obligan a pensar en DRESS, SSJ/NET.
- Tratamiento inicial: suspender el fármaco sospechoso y evitarlo en el futuro (registrar en la ficha), antihistamínico oral, corticoide tópico de mediana potencia y emolientes; corticoide oral breve solo en formas extensas.

- Seguimiento completo: control de la resolución, educación al paciente y derivar a alergología si se necesita pruebas o alternativas terapéuticas.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años consulta por tercera vez en un año por una mancha redonda de 3 cm en el dorso de la mano, eritematoviolácea, con ardor, que aparece siempre en el mismo sitio unas horas después de tomar ibuprofeno por dismenorrea. Al resolverse deja una mancha café grisácea. No tiene compromiso de mucosas ni fiebre. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Eritema multiforme menor
B) Dermatitis de contacto alérgica
C) Urticaria aguda
D) Síndrome de Stevens-Johnson
E) Eritema pigmentado fijo

Respuesta E. La toxidermia fija o eritema pigmentado fijo es una placa eritematoviolácea que reaparece siempre en el mismo sitio tras reexponerse al mismo fármaco, típicamente AINEs, cotrimoxazol o tetraciclinas, y deja hiperpigmentación residual. El tratamiento es suspender y evitar el fármaco.

Pregunta de práctica

Hombre de 60 años, con insuficiencia renal crónica, inició alopurinol hace 5 semanas por una crisis de gota. Consulta por fiebre de 39 °C de 4 días, edema facial marcado y un exantema morbiliforme confluente en tronco y extremidades, sin ampollas ni desprendimiento. Tiene adenopatías cervicales y axilares sensibles. El hemograma muestra 2.800 eosinófilos por microlitro y linfocitos atípicos; GOT y GPT están 8 veces sobre lo normal. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A) Urticaria aguda por alopurinol; antihistamínico H1 de segunda generación
B) Síndrome DRESS por alopurinol; suspender el fármaco e iniciar prednisona oral
C) Síndrome de Stevens-Johnson; traslado a Centro de Quemados
D) Hepatitis viral aguda; solicitar serología y observar
E) Eritema multiforme major; aciclovir oral

Respuesta B. Latencia de 5 semanas, fiebre, edema facial, adenopatías, eosinofilia marcada con linfocitos atípicos y hepatitis tóxica: Síndrome DRESS por alopurinol. La conducta es suspender el fármaco e iniciar prednisona oral, con descenso lento. No hay ampollas ni Nikolsky positivo para pensar en SSJ.

6.01.1.026 Rosácea

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.3 Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico

QUÉ HAY QUE SABER

- Rosácea: eritema centrofacial persistente con flushing, telangiectasias y, según subtipo, pápulas/pústulas, rinofima o compromiso ocular; mujeres adultas de piel clara. NUNCA hay comedones (si los hay es acné).
- Subtipos: 1 eritematotelangiectásico, 2 pápulo-pustuloso, 3 fimatoso (rinofima, en hombres), 4 ocular (blefaritis, chalazión recurrente). Desencadenantes: sol, calor, alcohol, picantes, estrés.
- Tratamiento inicial: fotoprotección FPS ≥50 diaria, evitar gatillantes y emolientes suaves. Eritema/flushing: brimonidina tópica; pápulo-pustulosa leve: metronidazol o ivermectina tópica; moderada-severa: doxiciclina oral dosis antiinflamatoria 8–12 semanas.
- Corticoide tópico está contraindicado (mejora por vasoconstricción y luego rebote: rosácea esteroidal, atrofia). Rinofima establecido: cirugía o láser CO2; ocular: higiene palpebral y lágrimas artificiales.
- Seguimiento completo por médico general; derivar rinofima, compromiso ocular o falta de respuesta.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 61

Una paciente de 30 años consulta por aparición de eritema, pápulas y pústulas en ambas mejillas, de varios meses de evolución, que aumentan con la exposición solar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Acné del adulto
B) Rosácea
C) Dermatomiositis
D) Erupción polimorfa solar
E) Lupus cutáneo crónico

Respuesta B. Eritema con pápulas y pústulas en mejillas que empeora con el sol: rosácea. El acné del adulto tendría comedones; la dermatomiositis daría otros signos cutáneos y debilidad muscular; la erupción polimorfa solar no tiene pústulas; el lupus cutáneo crónico es una o más placas de curso más lento, sin tantas pústulas.

Pregunta de práctica

Mujer de 38 años de tez clara consulta por enrojecimiento persistente en mejillas y nariz de 1 año de evolución, que empeora al tomar café caliente, beber vino tinto o salir al sol. En el último mes aparecieron pápulas y pústulas milimétricas en mejillas y dorso nasal, con telangiectasias visibles. No se identifican comedones en ninguna zona del rostro. **¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A) Clobetasol tópico de alta potencia por 2 semanas
B) Adapaleno tópico en monoterapia
C) Fotoprotección, evitar desencadenantes y metronidazol tópico
D) Doxiciclina oral 100 mg al día de forma indefinida
E) Isotretinoína oral por su componente pustuloso

Respuesta C. Eritema centrofacial que empeora con calor, alcohol y sol, con telangiectasias y pápulo-pústulas, sin comedones: rosácea pápulo-pustulosa. La primera línea es fotoprotección, evitar desencadenantes y metronidazol o ivermectina tópica. El corticoide está contraindicado; el adapaleno y la isotretinoína son de acné; la doxiciclina se reserva para formas moderadas-severas y por tiempo acotado.

6.01.1.027 Sarna

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Sarna (escabiosis, Sarcoptes scabiei): prurito intenso de predominio nocturno que afecta a varios convivientes; contagio por contacto piel con piel.
- Lesiones: surco acariano (línea fina serpenteante con vesícula perlada) en espacios interdigitales, cara anterior de muñecas, axilas, areolas, ombligo y genitales (nódulos escabióticos); respeta cara y espalda en el adulto, pero en lactantes puede afectar cuero cabelludo, palmas y plantas.
- Confirmación: acarotest (raspado del surco con visualización del ácaro, huevos o fecas); un resultado negativo no la descarta.
- Tratamiento: permetrina 5 % crema de cuello a pies, dejar 8–12 horas, repetir a los 7 días; ivermectina oral 200 μg/kg como alternativa. Tratar a TODOS los convivientes y contactos a la vez, tengan o no síntomas; lavar ropa de cama a >60 °C o aislar 72 horas en bolsa.
- Seguimiento completo: el prurito puede persistir 2–4 semanas tras curar; reevaluar si hay lesiones nuevas, tratar impétigo secundario y notificar brotes (institucionales).

PREGUNTAS (5)

Pregunta de práctica

Niña de 9 años consulta con su madre por prurito intenso de predominio nocturno, de 3 semanas de evolución, que también afecta a su hermano menor. Al examen se aprecian pápulas eritematosas con pequeños surcos lineales en los espacios interdigitales de ambas manos y en la cara anterior de las muñecas. **¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A) Permetrina al 5% en la niña, dejando al hermano en observación por ahora
B) Permetrina al 5% simultánea en la niña y en todos los convivientes del hogar
C) Corticoide tópico de alta potencia para el prurito, y control en 2 semanas
D) Antihistamínico oral exclusivo, sin tratamiento tópico
E) Ivermectina oral solo si el acarotest resulta positivo

Respuesta B. Prurito nocturno con surcos acarianos interdigitales, que afecta a más de un miembro de la familia: escabiosis. El tratamiento de elección es permetrina al 5% aplicada de forma simultánea a todos los convivientes, tengan o no síntomas, para evitar la reinfección.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 17 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 35 años consulta por intenso prurito en la zona genital de una semana de evolución. Al examen físico, se observan lesiones escrotales, que se muestran en la imagen (fuente: https://rafalafena.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/03/....). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Prúrigo nodular
B) Infección por virus papiloma humano
C) Sífilis primaria
D) Escabiosis
E) Sífilis secundaria

Respuesta D. Sarna Nodular: La presencia de prurito en la zona genital puede ser compatible con escabiosis (sarna) o infestación por ladillas (Phthirus pubis). Sin embargo, si las imágenes muestran lesiones nodulares características, se confirma el diagnóstico de sarna nodular.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 108 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada de 30 semanas, sin antecedentes, consulta por lesiones eritematosas en antebrazos, genitales, manos y tronco, asociadas a prurito. Al examen físico se aprecian lesiones eritematosas pápulares y maculares en patrón sinuoso, con signos de grataje, por lo que se decide realizar un ácaro test, que resulta positivo. El tratamiento de elección, en este caso es:

A) Permetrina oral
B) Puvaterapia
C) Corticoides locales
D) Permetrina tópica al 5%
E) Vaselina azufrada

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Vaselina azufrada (opción E). Sarna en embarazo = vaselina azufrada. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 91 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 34 años, cursando embarazo de 23 semanas, presenta lesiones pruriginosas en abdomen, manos y zona inguinal, que han ido en aumento en la úl8ma semana. Al examen Fsico se aprecian signos de rascado, pápulas y surcos en la zona interdigital y antebrazos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Betametasona tópica
B) Vaselina azufrada tópica
C) Loción de permetrina 5% tópica
D) Ivermec2na oral
E) Prednisona oral

Respuesta B. Es una pregunta discuGble. La normativa chilena vigente es muy antigua (Norma técnica 101 Minsal del año 2007, aunque ha sido replicada en normas más actuales) y aún prioriza la vaselina azufrada por su inocuidad total en embarazadas, lactancia y niños menores de 2 meses (por eso la dejaremos como correcta, ya que probablemente fue la correcta en el examen). Sin embargo, la evidencia moderna es cl

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 4 · texto original del banco, sin revisar

Clínica de Sarna (perlada) con acarotest negativo manejo:

A) Permetrina
B) Ivermectina
C) Repetir acarotest
D) Vaselina azufrada
E) Amoxicilina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Permetrina (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Ivermectina, Repetir acarotest) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del pacient

6.01.1.028 Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica)

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: derma-17

QUÉ HAY QUE SABER

- Quiste epidérmico (infundibular): nódulo subcutáneo móvil, firme, con punto central (comedón) que drena material caseoso maloliente; puede inflamarse o infectarse (absceso). Tratamiento: exéresis completa de la cápsula en frío; si está infectado, drenaje y exéresis diferida.
- Lipoma: tumor de grasa blando, lobulado, móvil, indoloro, de crecimiento lento; exéresis si es sintomático, crece o es mayor de 5 cm (sospecha de liposarcoma si es profundo, firme y de crecimiento rápido: ecografía/RM antes de operar).
- Queratosis seborreica: placas pigmentadas, de aspecto «pegado», untuoso y verrugoso, en tronco de adultos mayores; benigna. Signo de Leser-Trélat: aparición brusca de múltiples lesiones, sospecha de neoplasia interna.
- Tratamiento completo: queratosis seborreica solo por razones estéticas o irritación (crioterapia, curetaje); en lesión dudosa u oscura realizar biopsia (diferencial con melanoma). Enviar a histología toda pieza extirpada.
- Seguimiento completo: control de la herida y recidiva; derivar a cirugía si es profundo, mayor de 5 cm, de crecimiento rápido o en localización de riesgo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 83

Paciente de 24 años presenta una cicatriz de gran tamaño en la zona esternal, secundaria a una cirugía torácica realizada hace 6 meses, que no ha respondido a la terapia compresiva. Al examen físico se observa una cicatriz que sobrepasa los bordes de la herida inicial, de aspecto rojo-violáceo y dolorosa a la palpación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cicatriz hipertrófica en fase activa
B) Queloide
C) Cuerpo extraño
D) Úlcera de Marjolin
E) Granuloma piógeno

Respuesta B. El queloide es una proliferación fibrosa benigna que sobrepasa los límites de la herida original, no regresa espontáneamente y predomina en zona esternal, hombros y lóbulos auriculares. La cicatriz hipertrófica se mantiene dentro de los bordes y tiende a mejorar. El tratamiento incluye corticoides intralesionales, presoterapia y silicona; la exéresis aislada recidiva.

6.01.1.029 Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.15 Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Queratosis actínica: lesión premaligna más frecuente; mácula o pápula eritematosa poco delimitada con escama seca adherente, áspera «como papel de lija» (se palpa antes de verse), en cara, orejas, dorso de manos, antebrazos y cuero cabelludo calvo; por radiación UV acumulada (mutación TP53). Es un carcinoma espinocelular in situ incipiente.
- Cuerno cutáneo: protrusión hiperqueratósica cónica; ~60 % tiene una QA en la base y ~20 % esconde un espinocelular: biopsiar siempre la base. Alarma: base indurada, dolor, crecimiento rápido o ulceración sugiere

carcinoma invasor.

- Enfermedad de Bowen: placa eritematoescamosa bien delimitada y lenta, carcinoma espinocelular in situ; se biopsia y trata (crioterapia, 5-FU, imiquimod, extirpación). Nevo displásico: marcador de riesgo de melanoma, no cáncer; biopsia excisional si atipia marcada o cambios; si atipia leve y estable, seguimiento fotográfico.
- Tratamiento inicial: lesión aislada → crioterapia con nitrógeno líquido; múltiples lesiones o campo de cancerización → imiquimod 5 % o 5-fluorouracilo 5 % tópico (el eritema intenso indica respuesta), más fotoprotección estricta.
- Seguimiento completo: control periódico de la piel fotoexpuesta, educación en fotoprotección y derivar lesiones sospechosas de progresión.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Un hombre de 65 años presenta en la frente y dorso de manos varias máculas eritematosas milimétricas cubiertas por escamas ásperas muy adherentes, que al frotarlas suavemente con el dedo se sienten rugosas como lija. No hay induración ni signos inflamatorios profundos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Queratosis actínicas
B) Queratosis seborreicas
C) Psoriasis vulgar
D) Lupus eritematoso discoide
E) Linfoma cutáneo de células T

Respuesta A. Máculas eritematosas poco delimitadas con escamas adherentes ásperas al tacto (signo de la lija) en zonas fotoexpuestas crónicas son patognomónicas de las queratosis actínicas.

Pregunta de práctica

Mujer de 68 años, agricultora, consulta por múltiples lesiones ásperas de 3 a 5 mm en mejillas, nariz y dorso de ambas manos, que nota "como escamas que no se despegan". Al tacto, la piel se siente rugosa, como papel de lija. Ninguna lesión tiene base indurada ni ha crecido rápido en el último tiempo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Crioterapia focal sobre cada lesión, una por una, sin más medidas
B) Combinar crioterapia en las más gruesas con Imiquimod o 5-Fluorouracilo en el campo, más fotoprotección estricta
C) Biopsia excisional de todas las lesiones antes de decidir tratamiento
D) Observación clínica sin tratamiento, con control en un año
E) Corticoide tópico de alta potencia por 4 semanas

Respuesta B. Múltiples queratosis actínicas en zonas fotoexpuestas extensas corresponden a un campo de cancerización. El tratamiento combina destrucción focal de las lesiones más gruesas (crioterapia) con tratamiento médico del campo completo (Imiquimod o 5-Fluorouracilo) y fotoprotección estricta. No hay signos de alarma que justifiquen biopsiar todas las lesiones.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 72 años, con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en hemodiálisis, presenta aparición de una lesión en la cara anterior de la pierna derecha, eritematosa y descama8va, que inició hace cerca de 12 meses y ha ido aumentando progresivamente de tamaño. Al examen Fsico se observa la siguiente lesión: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Psoriasis
B) Derma22s de contacto
C) Eccema numular
D) Enfermedad de Bowen
E) Tiña

Respuesta D. Si bien por la ubicación y aspecto se podía pensar en una psoriasis, la edad, la evolución y la presencia de una única lesión es característica de la enfermedad de Bowen, que es un cáncer espinocelular in situ. Fuente imagen: hxps://iqb.es/dermatologia.

6.01.1.030 Urticaria aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.8 Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Urticaria aguda (<6 semanas): habones pruriginosos, sobreelevados, con halo pálido y evanescentes (cada lesión <24 h, sin dejar marca); degranulación de mastocitos. Causas: infecciones virales (lo más frecuente,

sobre todo en niños), fármacos (AINE, antibióticos) y alimentos.

- Confirmar: diagnóstico clínico; preguntar cuánto dura cada habón. Si el habón es fijo >24–48 h, deja púrpura o duele/arde, pensar en vasculitis urticariana y biopsiar. No requiere estudio alérgico de rutina (prick/IgE) en urticaria aguda.
- Tratamiento completo: suspender el gatillante y dar antihistamínico H1 de segunda generación (cetirizina, levocetirizina, desloratadina, loratadina) a dosis estándar; corticoide oral en ciclo ultracorto (3–5 días) solo en casos extensos o refractarios.
- Descartar anafilaxia (compromiso respiratorio, hemodinámico o digestivo): ahí la primera medida es adrenalina IM, no antihistamínicos.
- Seguimiento completo: control del cuadro; si persiste ≥6 semanas es urticaria crónica (antihistamínico hasta 4 veces la dosis, luego omalizumab: derivar).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 20

Mujer de 28 años con urticaria generalizada de 48 horas de evolución, con prurito intenso. Sin angioedema ni compromiso hemodinámico. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Levocetirizina oral
B) Adrenalina subcutánea
C) Metilprednisolona endovenosa
D) Omalizumab subcutáneo
E) Inmunoterapia sublingual

Respuesta A. Urticaria aguda sin signos de anafilaxia: la primera línea son los antihistamínicos H1 de segunda generación, como la levocetirizina. Los corticoides se reservan para casos refractarios y de rescate, no como primera línea.

Pregunta de práctica

Hombre de 32 años consulta por aparición recurrente de ronchas solevantadas, rojizas y muy pruriginosas en el tronco y las extremidades desde hace 3 meses, casi todos los días. Cada roncha individual dura entre 4 y 6 horas y desaparece sin dejar ninguna cicatriz ni marca, pero brotan otras nuevas en sitios diferentes. Ha usado desloratadina 5 miligramos al día sin lograr mejoría satisfactoria. No hay angioedema ni compromiso respiratorio. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar prednisona oral de mantenimiento por 3 meses
B) Aumentar la dosis del antihistamínico H1 hasta 4 veces la dosis estándar
C) Solicitar biopsia cutánea de inmediato
D) Administrar adrenalina intramuscular
E) Cambiar a un antihistamínico de primera generación como la clorfenamina

Respuesta B. Habones evanescentes, diarios, de más de 6 semanas de evolución, sin respuesta a dosis estándar de antihistamínico H1: urticaria crónica espontánea refractaria. El siguiente escalón según las guías internacionales es cuadruplicar la dosis del mismo antihistamínico H1 de segunda generación, no cambiar a corticoides ni a antihistamínicos sedantes de primera generación.

6.01.1.031 Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.12 Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

QUÉ HAY QUE SABER

- Verrugas (VPH): verruga vulgar = pápula hiperqueratósica rugosa con puntos negros (capilares trombosados) en manos y periungueal; plantar con dolor; plana en cara; condiloma acuminado exofítico anogenital (distinto del condiloma plano de la sífilis). Tratamiento: ácido salicílico tópico, crioterapia con nitrógeno líquido; condilomas con podofilotoxina o imiquimod.
- Molusco contagioso (poxvirus): pápulas perladas con umbilicación central en niños; autolimitado en meses; tratar con curetaje, crioterapia o hidróxido de potasio si se desea.
- Herpes simple: vesículas agrupadas sobre base eritematosa en labio (VHS-1) o genitales (VHS-2), precedidas de ardor; confirmar clínicamente (Tzanck o PCR). Aciclovir oral 400 mg cada 8 horas por 7–10 días o aciclovir tópico en herpes labial precoz; supresión si hay ≥6 recurrencias al año.
- Herpes zóster: reactivación del VVZ, dolor urente seguido de vesículas en racimo en un dermatoma unilateral que no cruza la línea media; aciclovir 800 mg 5 veces al día por 7 días (o valaciclovir 1 g cada 8 horas), idealmente en las primeras 72 horas; neuralgia postherpética con pregabalina, gabapentina o amitriptilina.

- Seguimiento completo: derivar zóster oftálmico (signo de Hutchinson) o Ramsay-Hunt, inmunosuprimidos con lesiones extensas y verrugas o condilomas refractarios.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 86

Un niño de 8 años presenta una lesión en la cara lateral del primer ortejo derecho. Al examen físico se aprecia una lesión hiperqueratósica, de superficie rugosa, con puntos negros en su superficie. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Queratosis seborreica
B) Melanoma
C) Panadizo
D) Verruga vulgar
E) Cuerpo extraño periungueal

Respuesta D. Una pápula hiperqueratósica rugosa con puntos negros, que son capilares trombosados, en la zona periungueal de un niño es una verruga vulgar por virus papiloma humano. La queratosis seborreica es del adulto mayor y el panadizo es una infección aguda dolorosa con pus.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 177 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 23 años consulta por aparición de lesiones dolorosas y pruriginosas en los pies, que aparecieron hace un mes y han aumentado. Al examen físico, se aprecia lo siguiente (fuente: podologíapriego): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tiña pedis
B) Verrugas plantares
C) Granuloma piógeno
D) Queratosis seborreica
E) Molusco contagioso

Respuesta B. Diagnóstico: Verrugas plantares (opción B). Son verrugas plantares clásicas.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 89 · texto original del banco, sin revisar

Adolescente de 20 años, consulta por la siguiente lesión, en el pliegue interglúteo, que presenta prurito y ardor: El diagnóstico más probable es:

A) Picadura de insecto
B) Consilomas acuminadas
C) Herpes simplex
D) Impétigo ampollar
E) Erisipela

Respuesta C. Diagnóstico: Herpes simplex (opción C). Imagen clásica. Es una recurrencia de herpes genital probablemente.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 43 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente adulto mayor, diabético, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, como se ve en la siguiente imagen: El tratamiento más adecuado es:

A) Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
B) Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 5 días
C) Aciclovir tópico
D) Loratadina 10 mg al día por 5 días
E) Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

Respuesta B. Tiene un herpes zóster. Sirven tanto el aciclovir, como el valaciclovir, pero solo la dosis del valaciclovir estaba bien, porque la de aciclovir, para herpes zóster es 800 mg cada 4 horas, por 5 a 7 días.

6.01.1.032 Vitiligo

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.1 Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

QUÉ HAY QUE SABER

- Vitiligo: enfermedad autoinmune con destrucción de melanocitos; máculas acrómicas (blancas) de bordes netos, sin descamación, simétricas en dorso de manos, periorificiales (boca, ojos), codos, rodillas y genitales; se acentúan con luz de Wood. Fenómeno de Koebner positivo.
- Asociación con autoinmunidad: tiroiditis de Hashimoto, diabetes tipo 1, anemia perniciosa, alopecia areata y enfermedad de Addison; pedir TSH y glicemia. Diferencial: pitiriasis versicolor (hipocrómica, descama al raspar), pitiriasis alba, lepra, hipopigmentación postinflamatoria.
- Tratamiento inicial: fotoprotección estricta de las zonas despigmentadas (riesgo de quemadura), corticoide tópico de mediana-alta potencia o inhibidor de calcineurina tópico (tacrolimus) en cara y pliegues.
- Fototerapia UVB de banda angosta en formas extensas o progresivas (especialista); camuflaje cosmético y apoyo psicológico.
- Seguimiento: derivar a dermatología para fototerapia o formas extensas; la repigmentación es lenta (meses) e incompleta en manos y pies.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años con manchas blancas de 1 año, simétricas, en dorso de manos, alrededor de la boca y en ambos codos. Son máculas acrómicas de bordes netos, sin descamación, que se acentúan con la luz de Wood. Tiene hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pitiriasis versicolor
B) Lepra tuberculoide
C) Hipopigmentación postinflamatoria
D) Pitiriasis alba
E) Vitiligo

Respuesta E. Máculas acrómicas (sin melanina), de bordes netos, simétricas en zonas periorificiales y acrales, que se intensifican con luz de Wood, son vitiligo, enfermedad autoinmune asociada a tiroiditis, diabetes tipo 1 y anemia perniciosa. Se trata con corticoides o inhibidores de calcineurina tópicos y fototerapia. La pitiriasis versicolor es hipocrómica y descama al rascado.

6.01.1.033 Vasculitis cutáneas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.22 Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Vasculitis cutánea de vaso pequeño (leucocitoclástica): púrpura palpable (pápulas purpúricas que no desaparecen a la vitropresión) en piernas y nalgas, a veces con ampollas o necrosis; aparece 1–3 semanas tras infección o fármaco (antibióticos, AINE).
- Púrpura de Henoch-Schönlein (vasculitis IgA): púrpura palpable en extremidades inferiores y nalgas con plaquetas normales, artralgias, dolor abdominal cólico y nefritis; ANCA negativos. Habitualmente en niños tras infección respiratoria.
- Sospecha: toda púrpura palpable obliga a buscar compromiso sistémico (orina con hematuria/proteinuria, creatinina, presión arterial) y causa (fármacos, infecciones, crioglobulinemia, hepatitis B y C, autoinmune); biopsia de lesión de <48 h con inmunofluorescencia confirma.
- Tratamiento inicial: suspender fármaco sospechoso, reposo y elevar extremidades, analgesia con paracetamol; Henoch-Schönlein es autolimitado (4–6 semanas), prednisona 1 mg/kg solo en dolor abdominal intenso o sangrado; ANCA (GPA/PAM): corticoides en pulsos + rituximab/ciclofosfamida y profilaxis con cotrimoxazol (especialista).
- Seguimiento: derivar a reumatología o nefrología si hay compromiso sistémico; en Henoch-Schönlein controlar orina y presión arterial por 6 meses. Habón fijo >24 horas que deja púrpura sugiere vasculitis urticariana.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años con lesiones en ambas piernas de 5 días, que aparecieron 1 semana después de iniciar amoxicilina por una sinusitis. Al examen se observan pápulas purpúricas palpables, que no desaparecen a la vitropresión, en ambas piernas y tobillos. Plaquetas normales, función renal y sedimento urinario normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?**

A) Púrpura trombocitopénica inmune; corticoides
B) Vasculitis leucocitoclástica (de pequeño vaso) por fármacos; suspender el antibiótico y confirmar con biopsia de piel
C) Meningococcemia; ceftriaxona
D) Escorbuto; vitamina C
E) Dermatitis de contacto; corticoide tópico

Respuesta B. La púrpura palpable en extremidades inferiores con plaquetas normales es la lesión típica de la vasculitis cutánea de pequeño vaso (leucocitoclástica), frecuentemente por fármacos o infecciones. Se suspende el agente gatillante, se confirma con biopsia y se buscan compromiso renal, digestivo y articular. La púrpura de la trombocitopenia no es palpable.

Situaciones clínicas de urgencia 16 códigos

6.01.2.001 Angioedema de Quinque

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.8 Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Angioedema: edema profundo (dermis profunda, subcutáneo, submucosa) de labios, párpados, lengua, genitales o laringe; tumefacción tensa que duele o tensa más que pica, y tarda 2–3 días en reabsorberse. Puede acompañar a la urticaria.
- Causas: alérgico/histaminérgico (alimentos, fármacos como AINE), por IECA (bradicininérgico, sin habones, no responde a antihistamínicos) y hereditario por déficit de inhibidor de C1 esterasa (C4 bajo, sin prurito ni habones).
- Bandera roja: disfonía, estridor, disnea, sensación de cierre de garganta, lengua hinchada o hipotensión = vía aérea en riesgo / anafilaxia.
- Tratamiento inicial: adrenalina IM 0,5 mg en adultos (0,01 mg/kg en niños) en cara anterolateral del muslo, repetible a los 5–15 min; asegurar vía aérea, O2 y vía venosa; antihistamínicos y corticoides EV solo como coadyuvantes. Suspender IECA/AINE. En angioedema hereditario: inhibidor de C1 o icatibant.
- Seguimiento: derivar/hospitalizar a unidad de urgencia; luego estudio etiológico por inmunología/alergología (C4, C1 inhibidor).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 28 años consulta 30 minutos después de comer mariscos por hinchazón progresiva de labios y lengua, con voz ronca y sensación de cierre de la garganta. Presión arterial 118/76, frecuencia cardíaca 104, saturación 95%. No tiene habones. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Clorfenamina oral y observación
B) Inhibidor C1 esterasa endovenoso
C) Prednisona oral y control al día siguiente
D) Adrenalina 0,5 mg intramuscular en la cara anterolateral del muslo
E) Alta con loratadina por 7 días

Respuesta D. Angioedema alérgico de labios y lengua con disfonía y sensación de cierre faríngeo indica compromiso de la vía aérea: es una emergencia. El tratamiento inmediato es adrenalina intramuscular, 0,5 mg en el adulto, en el muslo, repetible a los 5 a 15 minutos. Antihistamínicos y corticoides son coadyuvantes y no la reemplazan.

6.01.2.002 Ántrax

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Ántrax (carbunco estafilocócico, no el Bacillus anthracis): confluencia de varios forúnculos por S. aureus que forma una placa indurada muy dolorosa con múltiples orificios de drenaje («en espumadera»), típica en nuca y espalda de diabéticos.
- Sospecha: placa dolorosa >3–5 cm con pus por varios orificios, fiebre y malestar; factores: diabetes mal controlada, obesidad, inmunosupresión.
- Tratamiento inicial: drenaje quirúrgico (incisión y desbridamiento) más antibiótico sistémico antiestafilocócico (cloxacilina o cefazolina endovenosa; cubrir SAMR con cotrimoxazol, clindamicina o vancomicina según riesgo), analgesia y control de la glicemia.
- Hospitalizar si hay fiebre, diabetes descompensada, localización facial o extensión; tomar Gram y cultivo con antibiograma.
- Seguimiento: derivar a cirugía/dermatología para drenaje y curaciones; estudiar diabetes e inmunosupresión si no se conocían.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 60 años, diabético mal controlado, consulta por una placa indurada, muy dolorosa, de 6 cm en la nuca, con múltiples orificios por los que drena pus (aspecto en espumadera), de 5 días. Tiene fiebre de 38,5 °C. **¿Cuál es el diagnóstico y el manejo más adecuado?**
>
> **A)** Forúnculo simple; calor local
> **B)** Carbunco por Bacillus anthracis; ciprofloxacino y notificación
> **C)** Ántrax (carbunco estafilocócico); drenaje quirúrgico, antibiótico sistémico antiestafilocócico y control de la glicemia
> **D)** Quiste epidérmico infectado; exéresis electiva
> **E)** Hidradenitis supurativa; doxiciclina
>
> Respuesta C. El ántrax es la confluencia de varios forúnculos (S. aureus) que forman una placa inflamatoria con múltiples bocas de drenaje, típico en nuca y espalda de diabéticos. Es una infección profunda que requiere drenaje y antibiótico sistémico (cloxacilina o cefazolina, o según riesgo de SAMR) y compensación metabólica. El carbunco por B. anthracis es una escara negra indolora.

6.01.2.003 Erisipela / Celulitis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Erisipela: dermis superficial y linfáticos, S. pyogenes (>90 %); placa roja brillante, caliente, en «piel de naranja», con borde neto y sobreelevado, inicio brusco con fiebre alta y calofríos; piernas y cara (alas de mariposa). Linfedema es factor de riesgo.
- Celulitis: dermis profunda y subcutáneo, S. aureus y S. pyogenes; eritema, calor y edema con fóvea de bordes difusos, planos y mal delimitados; progresión en 24–48 horas. Buscar la puerta de entrada (tinea pedis, úlcera, herida).
- Tratamiento ambulatorio 7–10 días: marcar el borde con lápiz y reevaluar a las 24–48 horas; cefadroxilo 500 mg cada 12 horas, cefalexina 500 mg cada 6 horas o flucloxacilina 500 mg cada 8 horas (cubren ambos agentes); alérgicos: clindamicina 300 mg cada 8 horas; sospecha de SAMR: cotrimoxazol forte. Reposo con pierna elevada. Amoxicilina no cubre bien el estafilococo.
- Hospitalizar y dar cefazolina 1 g cada 8 horas o cloxacilina 1–2 g cada 4–6 horas EV si hay SIRS/sepsis, progresión tras 48 horas, comorbilidad descompensada (diabetes, cirrosis, inmunosupresión) o celulitis facial (riesgo de trombosis del seno cavernoso). Sospechar fascitis necrotizante si hay dolor desproporcionado, ampollas o shock.
- Seguimiento completo: control de evolución, tratar la puerta de entrada y prevenir recurrencias (manejo del linfedema, penicilina benzatina profiláctica si recurre).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 137

Una paciente de 62 años presenta una caída a nivel, con erosión en la rodilla derecha. Tres días después presenta una lesión eritematosa, que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes difusos, con aumento de la temperatura local. **¿Cuál es la conducta de elección?**

A) Indicar mupirocina tópica
B) Realizar curación con suero fisiológico y control en 48 horas
C) Realizar curaciones diarias con suero fisiológico y povidona yodada
D) Indicar amoxicilina oral por 7 días
E) Indicar cefadroxilo oral por 7 días

Respuesta E. Erosión como puerta de entrada + eritema de bordes difusos con calor local: celulitis. Requiere antibiótico sistémico que cubra S. aureus (cefadroxilo, flucloxacilina, cloxacilina; clindamicina en alérgicos). La amoxicilina no cubre bien al estafilococo y las medidas locales no bastan.

Pregunta de práctica

Mujer de 58 años con linfedema crónico de la pierna derecha tras safenectomía. Hace 12 horas inicia calofríos intensos, fiebre de 39 °C y dolor ardiente en esa pierna. En la cara anterior hay una placa eritematosa extensa, rojo brillante, indurada y dolorosa, con bordes nítidos y sobreelevados. Sin colecciones ni fluctuación. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Staphylococcus aureus meticilino resistente
B) Streptococcus pyogenes
C) Pseudomonas aeruginosa
D) Staphylococcus epidermidis
E) Escherichia coli

Respuesta B. Inicio súbito con fiebre alta y calofríos, placa rojo brillante con bordes nítidos y sobreelevados, sobre un linfedema: erisipela por Streptococcus pyogenes. Conducta: marcar el borde, reposo con la pierna elevada y cefadroxilo oral (o penicilina V o flucloxacilina); si hay compromiso del estado general, hospitalizar para cefazolina o penicilina G sódica EV.

6.01.2.004 Eritrodermia

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.5 Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Eritrodermia: eritema y descamación de >90 % de la superficie corporal; es una urgencia dermatológica por pérdida de calor, agua y proteínas, riesgo de insuficiencia cardíaca de alto gasto y sepsis.
- Causas: psoriasis (incluida la suspensión brusca de corticoides sistémicos), dermatitis atópica/eccema, reacciones a fármacos, linfoma cutáneo (síndrome de Sézary) e idiopática.
- Sospecha: fiebre o hipotermia, calofríos, edema de extremidades, taquicardia, adenopatías.
- Tratamiento inicial: hospitalizar, soporte (control de temperatura, balance hídrico y electrolítico, nutrición), emolientes, corticoide tópico de baja potencia, retirar fármacos sospechosos y prevenir infección. No dar corticoides sistémicos si es psoriasis.
- Seguimiento: derivar a dermatología para diagnóstico etiológico (biopsia) y tratamiento específico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 55 años con psoriasis en placas, que suspendió bruscamente prednisona oral indicada por un médico particular. Consulta por eritema y descamación de más del 90% de la superficie corporal, calofríos, temperatura de 38 °C y edema de extremidades. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Manejo ambulatorio con corticoide tópico de alta potencia en todo el cuerpo
B) Antihistamínico oral y control en 1 mes
C) Reiniciar prednisona en dosis altas y alta
D) Hospitalización para manejo de soporte (control de temperatura, balance hídrico y electrolítico, prevención de infecciones) y tratamiento por dermatología
E) Fototerapia ambulatoria

Respuesta D. La eritrodermia (eritema y descamación en más del 90% de la superficie) es una urgencia dermatológica: pérdida de calor, agua y proteínas, insuficiencia cardíaca de alto gasto e infección. Requiere hospitalización, soporte, emolientes, corticoide tópico de baja potencia y tratamiento de la causa (aquí psoriasis desencadenada por suspensión de corticoides sistémicos, que no deben usarse en psoriasis).

6.01.2.005 Fasceitis necrotizante

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

QUÉ HAY QUE SABER

- Fascitis necrotizante: infección rápidamente destructiva de fascia profunda y subcutáneo con trombosis microvascular. Tipo I polimicrobiana (80 %; diabéticos, cirugía perineal; gangrena de Fournier); tipo II por S. pyogenes (jóvenes tras trauma menor o varicela).
- Sospecha: dolor desproporcionado a una piel solo eritematosa, que sobrepasa los márgenes del eritema; luego signos duros: flictenas serohemáticas, crepitación, anestesia cutánea focal, piel violácea y shock séptico con lactato elevado.
- El diagnóstico es clínico: no retrasar el pabellón por imágenes ni punción. Diferencial con celulitis (dolor proporcional, hemodinamia estable).
- Tratamiento inicial: reanimación de shock séptico y traslado inmediato a pabellón para exploración, desbridamiento amplio y fasciotomía; antibióticos EV en paralelo: meropenem + vancomicina + clindamicina (la clindamicina bloquea la síntesis de toxinas estreptocócicas).
- Seguimiento: derivar y manejar en centro con cirugía y UCI; mortalidad aumenta con cada hora de demora. Angina de Ludwig (origen dental) es otra urgencia: asegurar vía aérea primero.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 50 años, diabética, con una herida en la pierna hace 3 días. Consulta por dolor intenso, desproporcionado a los hallazgos, con eritema mal delimitado, edema que se extiende más allá del eritema, ampollas violáceas y crépito a la palpación. Temperatura 39 °C, PA 90/55 mmHg, FC 120 lpm. **¿Cuál es la conducta más importante?**

A) Antibiótico oral y control en 48 horas
B) Resonancia magnética antes de decidir conducta
C) Elevación de la extremidad y cefazolina endovenosa
D) Reanimación, antibióticos endovenosos de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico urgente
E) Hospitalizar y observar la evolución de los bordes marcados

Respuesta D. Dolor desproporcionado, edema más allá del eritema, ampollas violáceas, crépito y shock son signos de fasceitis necrotizante. Es una emergencia quirúrgica: el desbridamiento precoz es el principal determinante de sobrevida, junto con antibióticos amplios (incluyendo clindamicina por efecto antitoxina) y reanimación. Las imágenes no deben retrasar la cirugía.

6.01.2.006 Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemangioma infantil: aparece en los primeros días-semanas, crece rápido durante los primeros 6–12 meses y luego involuciona; malformaciones vasculares están presentes desde el nacimiento y no involucionan (capilares

«mancha en vino de Oporto», venosas, linfáticas, arteriovenosas).

- Sospecha: lactante con placa o nódulo vascular rojo o azulado de crecimiento rápido; mancha en vino de Oporto en territorio V1 puede asociarse a Sturge-Weber (glaucoma, convulsiones) y síndrome de Klippel-Trenaunay en extremidades.
- Urgencia: hemangioma periorbitario que cubre la pupila, deforma la córnea o impide abrir el ojo, por riesgo de ambliopía; también vía aérea (barba), ulcerados o con falla hepática/cardíaca (hemangiomas múltiples).
- Tratamiento inicial: derivar con urgencia para iniciar propranolol oral (primera línea, 1–3 mg/kg/día, con control cardiovascular y glicemia) y evaluación oftalmológica; los pequeños y sin riesgo funcional se observan.
- Seguimiento: derivar a dermatología pediátrica/oftalmología/cirugía infantil; no usar corticoides tópicos ni esperar la involución en hemangiomas con riesgo funcional.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 6 semanas con un hemangioma infantil en el párpado superior derecho que apareció a los pocos días de vida y ha crecido rápidamente. Hoy cubre parcialmente la pupila e impide la apertura completa del ojo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Observación, ya que todos los hemangiomas involucionan
B) Láser ablativo inmediato en atención primaria
C) Derivar con urgencia para inicio de propranolol oral y evaluación oftalmológica por riesgo de ambliopía
D) Cirugía de exéresis electiva a los 5 años
E) Corticoide tópico de alta potencia

Respuesta C. Los hemangiomas infantiles crecen sobre todo en los primeros meses. Los periorbitarios que ocluyen el eje visual o deforman la córnea causan ambliopía (deprivación o astigmatismo) y requieren tratamiento precoz: propranolol oral, primera línea, iniciado por especialista. La observación solo es adecuada para hemangiomas pequeños sin riesgo funcional ni estético.

6.01.2.007 Herpes zoster

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

QUÉ HAY QUE SABER

- Herpes zóster: reactivación del virus varicela-zóster latente en ganglios sensitivos (por edad o inmunosupresión). Dolor neuropático urente que precede a vesículas agrupadas sobre base eritematosa en un dermatoma, estrictamente unilateral (no cruza la línea media).
- Diagnóstico clínico; confirmar con PCR o test de Tzanck solo en formas atípicas. Buscar formas especiales: zóster oftálmico (V1, signo de Hutchinson: vesículas en punta de la nariz; riesgo de queratitis y uveítis) y síndrome de Ramsay-Hunt (parálisis facial periférica, otalgia y vesículas en el conducto auditivo o pabellón).
- Tratamiento completo: aciclovir 800 mg oral 5 veces al día por 7 días, o valaciclovir 1 g cada 8 horas, idealmente en las primeras 72 horas; analgesia (paracetamol, AINE; opioides si es intenso) y curaciones. Ramsay-Hunt: aciclovir en dosis altas más corticoide oral.
- Neuralgia postherpética (dolor >3 meses): pregabalina, gabapentina o amitriptilina. Inmunosuprimidos o formas diseminadas: aciclovir endovenoso y hospitalización. Zóster oftálmico: evaluación oftalmológica urgente.
- Seguimiento completo por médico general: controlar cicatrización y dolor; indicar vacuna recombinante contra zóster en mayores de 50 años o inmunosuprimidos (donde esté disponible).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 116 · texto original del banco, sin revisar

Adulto mayor con dolor en cuero cabelludo seguido de vesículas en esa zona. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Aciclovir tópico 5% en crema
B) Famciclovir 500 mg cada 8 horas por 7 días
C) Prednisona oral 40 mg/día por 5 días
D) Gabapentina 300 mg cada 8 horas
E) Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días (opción E). Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días. Aspirina CONTRAINDICADA en varicela (síndrome de Reye). Tratamiento: paracetamol. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 158 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 76 años, diabética, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, asociada a dolor urente, como se ve en la siguiente imagen: El tratamiento más adecuado es:

A) Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
B) Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 7 días
C) Aciclovir tópico
D) Loratadina 10 mg al día por 5 días
E) Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

Respuesta B. El tratamiento del herpes zóster es con aciclovir 800 mg, 5 veces al día o con valaciclovir 1g c/8 horas, por un tiempo de 5 a 7 días. En cambio, los herpes simplex (genital o bucal) se tratan con la mitad de la dosis. Es muy raro que el Eunacom pregunte dosis de medicamentos, pero en esta pregunta era la única forma de elegir.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 170 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 37 años presenta dolor en el lado derecho de la cabeza, desde hace 2 días. El día de hoy aparecen lesiones en la piel, que se muestran a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Aciclovir 400 mg cada 6 horas, vía oral por 7 días
B) Fluloxacilina 500 mg cada 8 horas, vía oral por 7 días
C) Prednisona 40 mg al día, vía oral por 7 días
D) Mupirocina en crema al 1%, aplicar cada 8 horas, por 7 días
E) Valaciclovir 1 gramo vía oral cada 8 horas, por 7 días

Respuesta E. Diagnóstico: Valaciclovir 1 gramo vía oral cada 8 horas, por 7 días (opción E). Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años consulta por dolor urente en el hemitórax izquierdo desde hace 4 días. Desde hace 48 horas presenta vesículas agrupadas sobre base eritematosa que siguen una franja desde la columna hasta el esternón, sin cruzar la línea media. Está afebril, hemodinámicamente estable y no tiene inmunosupresión conocida. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Prednisona oral 1 mg/kg por 14 días como único tratamiento
B) Mupirocina tópica 2 % y control en 1 semana
C) Aciclovir oral 800 mg cinco veces al día por 7 días y analgesia
D) Amoxicilina-ácido clavulánico oral por 7 días
E) Pregabalina como único tratamiento, sin antiviral

Respuesta C. Dolor urente seguido de vesículas agrupadas en un dermatoma unilateral que no cruza la línea media corresponde a herpes zóster. El tratamiento es un antiviral oral (aciclovir 800 mg 5 veces al día por 7 días o valaciclovir 1 g cada 8 horas), idealmente en las primeras 72 horas, más analgesia. Los corticoides solos y los antibióticos no corresponden; la pregabalina se reserva para la neuralgia postherpética.

6.01.2.008 Loxocelismo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: derma-18

QUÉ HAY QUE SABER

- Loxoscelismo (Loxosceles laeta, «araña de rincón»): picadura habitualmente nocturna e indolora o de dolor leve al inicio, en domicilio (dormitorios, ropa, zapatos); más frecuente en verano y otoño en Chile.
- Cutáneo (más del 90 %): dolor progresivo e intenso en 2–8 horas, eritema, edema y placa livedoide violácea con ampolla; la necrosis evoluciona a escara negra y úlcera de cicatrización lenta en 1–3 semanas. Cutáneo-visceral (sistémico) en 24–72 horas: fiebre, ictericia, hemólisis, hemoglobinuria, insuficiencia renal aguda y CID.
- Diagnóstico clínico (antecedente de picadura o araña capturada y lesión característica); solicitar hemograma, LDH, bilirrubina, creatinina, orina completa y coagulación si hay sospecha de forma visceral.
- Tratamiento completo: cutáneo: reposo y elevación, frío local (no calor), analgesia, profilaxis antitetánica, aseo y curación de la úlcera; antibiótico solo si hay infección. Forma sistémica: hospitalizar con hidratación y corticoide EV, y suero antiloxoscélico si se presenta precoz (<24–48 horas) según disponibilidad.
- Seguimiento completo: control de herida hasta cicatrización y derivar a cirugía las úlceras que requieran desbridamiento o injerto; educar en prevención domiciliaria.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 89

Paciente consulta por una lesión en el antebrazo que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que luego de 6 horas se volvió más oscura y más grande. Al examen físico se aprecia una placa livedoide en el antebrazo, con zonas violáceas e isquémicas alternadas con áreas pálidas y halo eritematoso. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Loxoscelismo cutáneo
B) Necrosis grasa
C) Ectima
D) Pioderma gangrenoso
E) Fasceítis necrotizante

Respuesta A. Una lesión inicialmente dolorosa que en horas evoluciona a placa livedoide (zonas violáceas, pálidas y eritematosas) es la mordedura de araña de rincón (Loxosceles laeta). Se maneja con frío local, analgesia, antihistamínico y profilaxis antitetánica, y se controla a las 24 a 48 horas buscando hemólisis y hematuria (loxoscelismo cutáneo-visceral).

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 149 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con dolor en zona escapular izquierda y lesión ulcerada con halo violáceo. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A) Latrodectus mactans (araña del trigo)
B) Paederus irritans (bicho candela)
C) Miasis cutánea
D) Loxosceles laeta (araña de rincón)
E) Picadura de abeja con reacción local

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Loxosceles laeta (araña de rincón)). Loxosceles laeta (araña de rincón). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

6.01.2.009 Necrolisis tóxica epidérmica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.9 Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

QUÉ HAY QUE SABER

- Necrólisis epidérmica tóxica (Lyell): reacción grave a fármacos (sulfonamidas, alopurinol, anticonvulsivantes aromáticos, oxicams, betalactámicos) con latencia de 1–4 semanas; apoptosis masiva de la epidermis mediada por T CD8 y granulisina.
- Pródromo pseudogripal con ardor ocular, luego dianas atípicas de 2 anillos, dolor cutáneo desproporcionado, ampollas flácidas que confluyen, signo de Nikolsky positivo y compromiso de ≥2 mucosas (oral, ocular, genital). Desprendimiento >30 % de la superficie corporal = NET (SSJ <10 %; superposición 10–30 %); mortalidad 30–50 %.
- Tratamiento inicial: suspender de inmediato todo fármaco sospechoso (últimas 8 semanas), trasladar a UCI o centro de quemados, fluidoterapia, sala térmica 30–32 °C, curación con apósitos no adherentes, analgesia y nutrición.
- Calcular SCORTEN en las primeras 48 horas (edad ≥40, FC ≥120, cáncer, desprendimiento >10 %, urea >28 mg/dL, bicarbonato <20, glicemia >252). No desbridar la piel desprendida (actúa como apósito biológico).
- Interconsulta oftalmológica urgente desde el primer día (lisis de sinequias, lágrimas sin conservantes) para prevenir simblefaron. Seguimiento: derivar y manejar en centro de quemados.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 158

Una paciente de 76 años, diabética, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, asociada a dolor urente, como se ve en la siguiente imagen: **El tratamiento más adecuado es:**

A) Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
B) Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 7 días
C) Aciclovir tópico
D) Loratadina 10 mg al día por 5 días
E) Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

Respuesta B. Herpes zóster en una adulta mayor diabética: valaciclovir 1 g cada 8 horas por 7 días, o aciclovir 800 mg 5 veces al día. La opción A tiene dosis de herpes simple, insuficiente para el zóster; el tópico no sirve.

Pregunta de práctica

Una mujer de 68 años consulta por intenso dolor urente en la hemicara izquierda de 3 días de evolución, asociándose hace 24 horas a la aparición de vesículas en racimo en la frente, el párpado superior y la punta de la nariz (signo de Hutchinson positivo). **¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A) Iniciar Aciclovir oral a dosis plenas y solicitar evaluación urgente por Oftalmología
B) Indicar tratamiento con Carbamazepina y analgesia con Paracetamol
C) Aplicar ungüento tópico de corticoides en las lesiones nasales y párpado
D) Administrar vacuna de refuerzo contra herpes zóster
E) Realizar desbridamiento quirúrgico de las vesículas nasales

Respuesta A. Herpes zóster oftálmico con signo de Hutchinson: compromiso del nervio nasociliar (V1) que predice afectación corneal grave. Conducta: aciclovir oral (800 mg 5 veces al día) o valaciclovir, y derivación urgente a Oftalmología.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 48 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre y dolor cutáneo generalizado, con eritema generalizado de la piel y compromiso de las mucosas. Hace algunas horas comienza con aparición de ampollas generalizadas. Al examen físico se observa lo mostrado en la siguiente imagen: El diagnóstico más probable es:

A) Psoriasis eritrodérmica
B) Escarlatina quirúrgica
C) Pustulosis exantemática
D) Necrosis epidermolítica tóxica
E) Pénfigo

Respuesta D. Es una NET clásica, con el signo de Kikolski (se desprende la epidermis), aunque no era la imagen más característica de la NET.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 94 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los ojos, lesiones en la boca, malestar general y aparición de un rash cutáneo. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y un exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades, con lesiones en la cara similares a las de la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Gingivoestomatitis herpética
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Pénfigo
E) Escarlatina

Respuesta A. Síndrome de Stevens-Johnson: El cuadro clínico con compromiso de mucosas (oral, ocular), rash cutáneo con pápulas/placas eritematosas y antecedente de uso de antibiótico (amoxicilina) son característicos del síndrome de Stevens-Johnson.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 80 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 45 años inicia tratamiento an8bió8co debido a una infección dental. Al sép8mo día de tratamiento presenta erupción papulovesicular generalizada y progresiva, que afecta tronco y extremidades, asociada a fiebre y malestar general. Al examen Fsico se aprecia lo siguiente: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Síndrome DRESS
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Síndrome de piel escaldada
E) Pénfigo ampollar

Respuesta C. Es una NET clásica, por la extensión generalizada y el desprendimiento de la epidermis en la imagen. El SSJ es la misma patología, pero más leve, con afectación de menos del 10% de la superficie cutánea.

6.01.2.010 Pénfigo y penfigoide

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.11 Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pénfigo vulgar: adulto 40–60 años, úlceras orales dolorosas primero, ampollas flácidas, Nikolsky positivo, acantolisis (IgG intercelular en red de pescar). Penfigoide ampollar: anciano (>70 años), prurito previo, ampollas tensas, Nikolsky negativo, boca casi siempre respetada, depósito lineal en la membrana basal (anti-BP180/BP230).
- Diferencial urgente: SSJ/NET (fármaco, dianas atípicas, mucosas), SSSS en niños, dermatitis herpetiforme (celiaquía, vesículas agrupadas en superficies extensoras; dapsona).
- Confirmación: biopsia de ampolla reciente para histología y de piel perilesional para inmunofluorescencia directa. No biopsiar erosiones antiguas.
- Tratamiento inicial: pénfigo → prednisona oral 1–1,5 mg/kg/día ± rituximab; penfigoide → clobetasol tópico en toda la piel (menor mortalidad que prednisona en ancianos); prednisona 0,5 mg/kg/día solo si es extenso. Cuidado de erosiones, hidratación, prevención de infección.
- Seguimiento: derivar a dermatología; hospitalizar los casos extensos, con compromiso mucoso severo o ancianos frágiles.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 16.11

Un hombre de 76 años, con antecedentes de enfermedad de Parkinson, consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de prurito generalizado severo, al que se agregó en las últimas dos semanas la aparición de múltiples ampollas de gran tamaño en el abdomen, ingles y caras internas de muslos. Al examen físico se aprecian numerosas ampollas de contenido seroso claro, de paredes gruesas, muy tensas y duras a la palpación, asentadas sobre placas eritematosas. La mucosa oral no presenta lesiones. Al frotar con fuerza moderada la piel sana perilesional, la epidermis no se despega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pénfigo vulgar
B) Penfigoide ampollar
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Dermatitis herpetiforme
E) Epidermólisis bullosa simple

Respuesta B. El cuadro clínico es patognomónico de Penfigoide Ampollar. Los hallazgos cardinales que lo confirman son: 1) Edad avanzada (76 años con patología neurológica crónica asociada); 2) Prurito intenso prodrómico; 3) Ampollas tensas, de paredes gruesas y resistentes que no se rompen fácilmente; 4) Signo de Nikolsky negativo (la epidermis sana no se desprende con la fricción); y 5) Ausencia de compromiso en la mucosa oral. El pénfigo vulgar (A) afectaría a personas más jóvenes (40-60 años), cursaría con ampollas flácidas muy frágiles, Nikolsky positivo y compromiso oral casi universal. La NET (C) es una farmacodermia aguda grave con Nikolsky positivo y desprendimiento masivo. La dermatitis herpetiforme (D) se asocia a celiaquía con vesículas en codos y rodillas.

6.01.2.011 Quemadura solar

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Quemadura solar: quemadura superficial (eritema doloroso, grado I) o de espesor parcial superficial (ampollas, grado II) por radiación UVB, 6–24 horas después de la exposición; edema, dolor y prurito, luego descamación.
- Específico: diagnóstico clínico por antecedente de exposición y distribución en zonas expuestas; el eritema de grado I no se cuenta para superficie quemada. Buscar compromiso sistémico (fiebre, escalofríos, náuseas, hipotensión: golpe de sol, deshidratación).
- Tratamiento completo ambulatorio: compresas frías, hidratación oral, AINE o paracetamol para el dolor, emolientes, corticoide tópico de baja potencia en casos intensos, no romper las ampollas; no usar antibióticos profilácticos.
- Hospitalizar si hay superficie extensa con ampollas, compromiso sistémico, deshidratación o lactantes/niños pequeños.
- Seguimiento: no requiere control habitual; educar en evitar exposición (10–16 h), fotoprotección FPS ≥30 y barreras físicas; las quemaduras en la infancia aumentan el riesgo de melanoma.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 22 años consulta 12 horas después de pasar 6 horas en la playa sin fotoprotector. Tiene eritema intenso, doloroso y edema en espalda y hombros, con algunas ampollas pequeñas en los hombros. Está afebril, hidratada, sin compromiso del estado general. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Hospitalización y reanimación con fórmula de Parkland
B) Compresas frías, hidratación oral, AINE para el dolor, emolientes, no romper las ampollas y fotoprotección estricta
C) Corticoide sistémico en dosis altas
D) Antibiótico oral profiláctico
E) Aplicar pasta de dientes o mantequilla sobre la quemadura

Respuesta B. La quemadura solar es una quemadura superficial (eritema) o intermedia superficial (ampollas) por radiación UV. Sin compromiso sistémico se maneja ambulatoriamente con frío local, analgesia (AINE), hidratación, emolientes, cuidado de ampollas y evitar el sol. Se hospitaliza si es extensa con ampollas, hay deshidratación, fiebre o compromiso general, sobre todo en niños.

6.01.2.012 Sífilis congénita

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

QUÉ HAY QUE SABER

- Sífilis congénita: transmisión transplacentaria de T. pallidum por madre con sífilis no tratada o mal tratada; prevención con tamizaje y tratamiento de la embarazada (GES sífilis en embarazo).
- Sospecha en el recién nacido: hepatoesplenomegalia, rinitis serosanguinolenta persistente (coriza), lesiones ampollares descamativas en palmas y plantas (pénfigo sifilítico), ictericia, anemia, lesiones óseas (osteocondritis), o asintomático con VDRL materno reactivo.
- Estudio inicial: VDRL en sangre del RN (título cuatro veces mayor que el materno es sugerente) y en LCR, hemograma, pruebas hepáticas, radiografía de huesos largos y fondo de ojo; el tratamiento no debe esperar.
- Tratamiento inicial: penicilina sódica EV por 10 días (50.000 UI/kg cada 12 horas la primera semana y cada 8 horas después); la penicilina benzatina no alcanza niveles en el sistema nervioso central.
- Seguimiento: derivar a neonatología/infectología; control con VDRL seriado hasta negativizar, evaluación neurológica y auditiva, y tratar a la madre y a sus contactos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de término, hijo de madre con VDRL reactivo 1:32 en el parto, sin control prenatal ni tratamiento. Al examen tiene hepatoesplenomegalia, rinitis serosanguinolenta persistente y lesiones ampollares descamativas en palmas y plantas. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Penicilina benzatina intramuscular dosis única
B) Observación y VDRL a los 3 meses
C) Ceftriaxona intramuscular por 3 días
D) Azitromicina oral por 5 días
E) Penicilina sódica endovenosa por 10 días, previo estudio con VDRL en sangre y LCR

Respuesta E. Un recién nacido con signos clínicos (hepatoesplenomegalia, coriza, pénfigo sifilítico palmoplantar) de madre con sífilis no tratada tiene sífilis congénita. Se estudia con VDRL en sangre y LCR, hemograma, radiografía de huesos largos y fondo de ojo, y se trata con penicilina sódica endovenosa por 10 días. La benzatina no alcanza niveles en el sistema nervioso central.

6.01.2.013 Síndrome de hipersensibilidad a drogas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.10 Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de hipersensibilidad a drogas (DRESS): fármaco (anticonvulsivantes aromáticos, alopurinol, sulfas, dapsona, betalactámicos) con latencia larga de 2–8 semanas; reactivación de herpesvirus 6.
- Tríada: fiebre >38,5 °C, exantema morbiliforme confluente con edema facial periorbitario y adenopatías en ≥2 cadenas. Sin ampollas ni Nikolsky positivo. Eosinofilia y linfocitos atípicos; criterios RegiSCAR (≥4 puntos probable).

- El pronóstico lo define el órgano: hepatitis (75–90 %), nefritis tubulointersticial (sobre todo alopurinol), miocarditis (puede debutar semanas después) y neumonitis. Pedir hemograma, perfil hepático, creatinina y troponinas si hay síntomas.
- Tratamiento inicial: suspender el fármaco de inmediato y no reintroducir (reacción cruzada entre anticonvulsivantes aromáticos); hospitalizar si hay compromiso visceral; prednisona 0,5–1 mg/kg/día o metilprednisolona EV si hepatitis grave.
- Seguimiento completo: descenso muy lento de corticoides en 2–3 meses (bajar rápido provoca recaída fulminante) y control de función tiroidea a los 2 y 6 meses.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 94

Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los ojos, lesiones en la boca, malestar general y aparición de un rash cutáneo. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y un exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Gingivoestomatitis herpética
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Pénfigo
E) Escarlatina

Respuesta A. Compromiso de mucosas oral y ocular, exantema con pápulas y placas, y latencia de 14 días con un fármaco de riesgo como la amoxicilina: Síndrome de Stevens-Johnson. La gingivoestomatitis herpética no explica el compromiso ocular ni el exantema del tronco.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 48

Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre y dolor cutáneo generalizado, con eritema generalizado de la piel y compromiso de las mucosas. Hace algunas horas comienza con aparición de ampollas generalizadas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Psoriasis eritrodérmica
B) Escarlatina quirúrgica
C) Pustulosis exantemática
D) Necrólisis epidérmica tóxica
E) Pénfigo

Respuesta D. Latencia de 2 semanas tras una cirugía (con fármacos perioperatorios, típicamente betalactámicos), dolor cutáneo desproporcionado, eritema generalizado, compromiso de mucosas y ampollas generalizadas con desprendimiento: Necrólisis Epidérmica Tóxica.

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años, con antecedente de crisis de gota, inició cotrimoxazol hace 12 días por una infección urinaria. Consulta por 3 días de fiebre de 38,8 °C, dolor faríngeo y ardor ocular, a lo que se agrega hoy una erupción dolorosa con máculas purpúricas de 2 anillos en tronco y algunas flictenas. Al examen presenta desprendimiento epidérmico estimado en 6% de la superficie corporal, úlceras orales con costras hemáticas y conjuntivitis bilateral. Al frotar suavemente la piel eritematosa perilesional, la epidermis se desprende con facilidad. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata más adecuada?**

A) Urticaria aguda; iniciar antihistamínico H1 de segunda generación
B) Eritema multiforme major; observación ambulatoria con antivirales
C) Síndrome de Stevens-Johnson; suspender el cotrimoxazol y hospitalizar
D) Necrólisis epidérmica tóxica; traslado a Centro de Quemados
E) Penfigoide ampollar; iniciar clobetasol tópico de alta potencia

Respuesta C. Latencia de 12 días con cotrimoxazol, pródromo pseudogripal, dianas atípicas de 2 anillos, Nikolsky positivo, desprendimiento del 6% de la BSA y compromiso de 2 mucosas: Síndrome de Stevens-Johnson. La conducta inmediata es suspender el fármaco y hospitalizar. NET requeriría más del 30%; el eritema multiforme no despega la piel; el penfigoide es Nikolsky negativo y en ancianos.

6.01.2.014 Síndrome de piel escaldada por estafilococos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 16.9 Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de piel escaldada por estafilococos (SSSS): toxina exfoliativa de S. aureus que causa despegamiento intraepidérmico superficial a distancia del foco; sobre todo en niños <5 años (conjuntivitis, impétigo, faringitis previos).
- Fiebre e irritabilidad, eritema doloroso difuso más intenso en pliegues y periorificial, costras radiadas alrededor de la boca, ampollas flácidas que dejan áreas denudadas; Nikolsky positivo; mucosas respetadas (clave frente a NET).
- Tratamiento inicial: hospitalizar y antibiótico antiestafilocócico endovenoso (cloxacilina o cefazolina; clindamicina si sospecha de SAMR), hidratación, analgesia, emolientes y control térmico. Corticoides contraindicados.
- Diferencial: NET/SSJ (adultos, fármacos, mucosas afectadas, biopsia con necrosis de toda la epidermis), impétigo ampolloso localizado, quemadura, pénfigo foliáceo.
- Seguimiento: no requiere; buen pronóstico en niños, cura sin cicatriz en 1–2 semanas. Buscar y tratar el foco infeccioso y contactos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 3 años con fiebre e irritabilidad de 2 días tras una conjuntivitis purulenta. Presenta eritema difuso, doloroso al tacto, más intenso en pliegues y periorificial, con costras radiadas alrededor de la boca y ampollas flácidas que se rompen dejando áreas denudadas. Nikolsky positivo. Las mucosas oral y conjuntival no tienen erosiones. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) Síndrome de piel escaldada por estafilococo; hospitalización y cloxacilina (o cefazolina) endovenosa con soporte
B) Necrólisis epidérmica tóxica; suspender fármacos e inmunoglobulina
C) Impétigo ampollar localizado; mupirocina
D) Escarlatina; amoxicilina oral
E) Pénfigo vulgar; corticoides sistémicos

Respuesta A. En niños pequeños, una toxina exfoliativa del S. aureus produce despegamiento intraepidérmico superficial (granuloso) a distancia del foco: eritema doloroso, Nikolsky positivo y costras periorificiales, sin compromiso de mucosas. Se hospitaliza y trata con antiestafilocócico endovenoso y soporte (hidratación, analgesia). En la NET hay mucosas comprometidas y antecedente de fármaco.

6.01.2.015 Síndrome de Stevens-Johnson

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.9 Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de Stevens-Johnson: reacción adversa grave a fármacos (cotrimoxazol, alopurinol, carbamazepina/fenitoína, oxicams, aminopenicilinas) con latencia de 1–4 semanas; menos común por Mycoplasma o infecciones.
- Pródromo febril con ardor ocular y odinofagia; luego dianas atípicas de 2 anillos y ampollas con dolor cutáneo intenso, Nikolsky positivo, y erosiones hemorrágicas con costras en ≥2 mucosas (>90 %). Desprendimiento <10 % de la superficie (10–30 % superposición; >30 % NET).
- Diferenciar de eritema multiforme menor (dianas típicas de 3 anillos, sin despegamiento, mucosa mínima, gatillado por herpes) y de DRESS (latencia 2–8 semanas, edema facial, eosinofilia).
- Tratamiento inicial: suspender el fármaco sospechoso de inmediato, hospitalizar (UCI/quemados si progresa), hidratación, control térmico, curaciones atraumáticas, analgesia, evaluación oftalmológica urgente; calcular SCORTEN. No usar antihistamínicos como único manejo.
- Seguimiento: derivar a centro con unidad de quemados y dermatología; registrar la alergia al fármaco de por vida.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 76 años, con antecedente de enfermedad de Parkinson, consulta por 2 meses de prurito generalizado severo, al que se agregó en las últimas 2 semanas la aparición de múltiples ampollas de gran tamaño en el abdomen, las ingles y las caras internas de los muslos. Al examen se aprecian ampollas de contenido seroso claro, de paredes gruesas y muy tensas, sobre placas eritematosas. La mucosa oral no presenta lesiones. Al frotar con fuerza moderada la piel sana cercana, la epidermis no se despega. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pénfigo vulgar
B) Penfigoide ampollar
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Dermatitis herpetiforme
E) Epidermólisis bullosa simple

Respuesta B. Edad avanzada con patología neurológica de base, prurito intenso prodrómico, ampollas tensas y resistentes, Nikolsky negativo y mucosa oral respetada: Penfigoide Ampollar. El pénfigo afectaría a un paciente más joven, con ampollas flácidas, Nikolsky positivo y compromiso oral casi universal.

6.01.2.016 Urticaria y angioedema

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.8 Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Urticaria con o sin angioedema: habones evanescentes (<24 h) y/o edema profundo de labios, párpados, lengua. Aguda <6 semanas; crónica ≥6 semanas, mayormente espontánea y autoinmune (autoanticuerpos contra IgE/receptor del mastocito).
- Distinguir de vasculitis urticariana (habón fijo >24–48 h, doloroso, deja púrpura): biopsia cutánea. Anafilaxia si hay compromiso respiratorio, hemodinámico o digestivo: adrenalina IM de inmediato.
- Tratamiento completo sin anafilaxia: suspender desencadenante (AINE, alimento), antihistamínico H1 de segunda generación a dosis estándar (cetirizina, levocetirizina, desloratadina); corticoide oral solo ciclo ultracorto de rescate.
- Urticaria crónica: si no hay control en 2–4 semanas, cuadruplicar la dosis del mismo antihistamínico; luego omalizumab y ciclosporina (especialista). Nunca corticoides orales como mantenimiento.
- Seguimiento completo: controles hasta remisión, educar sobre signos de anafilaxia y evitar AINE; derivar urticaria crónica refractaria.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años presenta, 1 hora después de tomar ibuprofeno, habones pruriginosos generalizados y edema de labios y párpados. No tiene disfonía, estridor, disnea, sibilancias, vómitos ni hipotensión. PA 120/75 mmHg, saturación 98%. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Adrenalina intramuscular y hospitalización en UCI
B) Concentrado de inhibidor de C1 esterasa
C) Intubación orotraqueal profiláctica
D) Suspender el AINE, antihistamínico H1 de segunda generación y eventual curso corto de corticoide oral, con observación y educación sobre signos de anafilaxia
E) Antibiótico oral

Respuesta D. Urticaria aguda con angioedema sin compromiso de vía aérea, respiratorio, digestivo ni hemodinámico no es anafilaxia: se suspende el desencadenante y se indican antihistamínicos H1 de segunda generación (pueden aumentarse hasta 4 veces la dosis), con corticoide oral breve si es extensa. La adrenalina IM se reserva para anafilaxia o angioedema laríngeo.

Conocimientos generales 3 códigos

6.01.3.001 Fotoprotección

Dónde se enseña: Tema 16.14 Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Principal medida de prevención primaria del cáncer de piel (basocelular, espinocelular y melanoma) y del fotoenvejecimiento; las quemaduras solares en la infancia aumentan el riesgo de melanoma y la dosis acumulada el de espinocelular. Chile tiene alta radiación UV (Índice UV extremo en verano).
- Evitar la exposición entre las 10 y 16 horas; barreras físicas: sombra, ropa de manga larga, sombrero de ala ancha y lentes con filtro UV; no usar camas solares (aumentan el riesgo de melanoma).
- Fotoprotector de amplio espectro (UVA y UVB) FPS ≥30, en cantidad suficiente, aplicado 15–30 minutos antes de la exposición y reaplicado cada 2–3 horas y tras el baño o sudor, incluso con nublado; mayor FPS en fototipos claros.
- Lactantes <6 meses: evitar exposición directa y priorizar sombra y ropa (sin filtros químicos como primera medida); niños: educación escolar sobre sol seguro.
- Poblaciones de mayor riesgo: fototipo claro, trabajadores al aire libre, trasplantados y pacientes con fotodermatosis, queratosis actínicas o antecedente de cáncer de piel; enseñar autoexamen mensual de nevos (ABCDE).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Madre consulta en control sano sobre medidas de fotoprotección para su hijo de 4 años y para ella, que tiene fototipo II. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A) Usar fotoprotector solo los días soleados de verano

B) Evitar la exposición entre las 10 y 16 horas, usar ropa, sombrero y lentes con filtro UV, y fotoprotector FPS 30 o más, reaplicado cada 2 a 3 horas y tras bañarse

C) Aplicar fotoprotector una vez al día en la mañana es suficiente

D) Las camas solares previas al verano protegen contra quemaduras

E) En lactantes menores de 6 meses se recomienda fotoprotector químico abundante como primera medida

Respuesta B. La fotoprotección se basa en evitar el sol del mediodía, medidas físicas (sombra, ropa, sombrero, lentes) y fotoprotector de amplio espectro FPS 30 o más, aplicado 30 minutos antes y reaplicado cada 2 a 3 horas y tras el agua, incluso nublado. Las camas solares aumentan el riesgo de melanoma. Bajo 6 meses priman las medidas físicas.

6.01.3.002 Higiene de la vivienda y profilaxis del loxoscelismo

Dónde se enseña: derma-18

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivo: reducir el contacto con Loxosceles laeta en el domicilio; la araña habita en rincones oscuros y secos, detrás de muebles, cuadros, ropa guardada y zapatos.
- Medidas de orden y aseo: despejar y limpiar periódicamente los rincones, aspirar y retirar telarañas, no acumular ropa, cajas ni papeles; sacudir ropa y zapatos antes de usarlos, sobre todo si estuvieron guardados.
- Cama y dormitorio: separar la cama de la pared, no dejar ropa de cama colgando hasta el suelo, revisar sábanas y toallas, y sellar grietas y espacios en muros y zócalos.
- Control químico solo con apoyo sanitario (desinsectación por empresas autorizadas); no manipular la araña con la mano, capturarla con un frasco para su identificación.
- Ante una picadura: consultar de inmediato, llevar la araña si es posible y no aplicar calor ni remedios caseros; educar a familias en zonas endémicas del país.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Familia de una zona rural consulta por haber encontrado arañas de rincón (Loxosceles laeta) en su casa. Preguntan cómo prevenir mordeduras. **¿Cuál es la medida de prevención más adecuada?**

A) Mantener la casa a oscuras y cerrada

B) Usar insecticida una vez al año como única medida

C) Aseo frecuente detrás de muebles y cuadros, separar camas de la pared, sacudir ropa, zapatos y toallas antes de usarlas, y evitar acumular objetos

D) Dormir con la ropa del día

E) Eliminar a las arañas tigre (Scytodes), que son sus predadoras

Respuesta C. La araña de rincón es nocturna y vive en lugares oscuros y tranquilos (detrás de cuadros, muebles, ropa guardada); la mayoría de las mordeduras ocurren al vestirse o en la cama. Se previene con aseo frecuente moviendo muebles, camas separadas de la pared y sacudir ropa y calzado. La araña tigre es su predador natural.

6.01.3.003 Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas

Dónde se enseña: Tema 16.1 Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

QUÉ HAY QUE SABER

- La piel refleja enfermedades sistémicas y puede ser la primera pista diagnóstica: el médico general debe reconocer los signos cutáneos y pedir el estudio adecuado.
- Diabetes: acantosis nigricans (resistencia a insulina, obesidad), necrobiosis lipoídica, candidiasis, infecciones y pie diabético. Tiroides: mixedema pretibial (Graves), vitíligo, piel seca (hipotiroidismo). Enfermedad celíaca: dermatitis herpetiforme. Autoinmune: eritema malar y fotosensibilidad (LES), heliotropo y pápulas de Gottron (dermatomiositis), esclerodactilia (esclerodermia).
- Infecciones/neoplasias: sífilis secundaria (exantema palmoplantar), VIH (dermatitis seborreica severa, sarcoma de Kaposi), eritema nodoso (estreptococo, TBC, sarcoidosis, EII), pioderma gangrenoso (EII, artritis), prurito generalizado (colestasis, uremia, linfoma), signo de Leser-Trélat.
- Hígado y riñón: ictericia, arañas vasculares y eritema palmar (cirrosis), púrpura; xerosis y prurito urémico. Hematología: palidez y petequias.
- Conducta: ante lesión cutánea sugerente, dirigir anamnesis y estudio de la enfermedad de base (glicemia, TSH, ANA, VDRL, VIH, función hepática y renal) y derivar a la especialidad correspondiente.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Una paciente de 25 años consulta por una erupción cutánea diseminada. El médico describe lesiones circunscritas de contenido líquido claro seroso, de 2 a 3 milímetros de diámetro, agrupadas en racimo sobre una base eritematosa en el labio superior. **¿Cuál es el nombre semiológico exacto de esta lesión elemental primaria?**

A) Pústula
B) Vesícula
C) Ampolla
D) Pápula
E) Erosión

Respuesta B. Colección circunscrita de líquido seroso en la epidermis, con diámetro menor a 0,5 cm: vesícula. La ampolla es mayor a 0,5–1 cm; la pústula tiene contenido purulento desde su origen; la pápula es sólida; la erosión es una lesión secundaria por pérdida de sustancia.

Pregunta de práctica

Hombre de 32 años consulta por lesiones pruriginosas en los codos. Al examen físico se aprecian lesiones sobreelevadas sólidas eritematosas que miden entre 3 y 5 cm de diámetro, con superficie aplanada en meseta y cubiertas por abundantes escamas plateadas que confluyen formando áreas extensas. **¿Cuál es el nombre semiológico correcto de esta lesión elemental?**

A) Mancha
B) Pápula
C) Placa
D) Nódulo
E) Habón

Respuesta C. Elevación sólida circunscrita, con diámetro mayor a 1 cm y extensión en superficie que supera su altura (en meseta), formada por confluencia de lesiones más pequeñas: placa. La descamación plateada sobre una placa en superficies de extensión es la lesión elemental clásica de la psoriasis vulgar.

Exámenes e imagenología 7 códigos

6.01.4.001 Acarotest

Nivel: **Realiza, interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Acarotest: examen para confirmar escabiosis; se busca un surco acariano o pápula no excoriada en espacios interdigitales, muñecas o genitales.

- Técnica: aplicar una gota de aceite mineral o KOH, raspar el surco con hoja de bisturí o cureta hasta eliminar el techo y observar al microscopio el ácaro (Sarcoptes scabiei), huevos o escíbalos.
- Indicación: prurito nocturno intenso con convivientes afectados, lesiones en pliegues interdigitales, muñecas, ombligo y genitales, o sospecha en lactantes y ancianos (sarna costrosa).
- Alta especificidad pero sensibilidad limitada: un acarotest negativo no excluye escabiosis; se trata igual si la clínica es compatible.
- El médico general realiza, interpreta y emplea el resultado: positivo confirma y justifica tratamiento simultáneo de todos los contactos con permetrina 5 %.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 35 años con prurito intenso de predominio nocturno de 3 semanas. Su pareja tiene síntomas similares. Al examen se observan pápulas excoriadas en espacios interdigitales, muñecas, ombligo y genitales, y algunos surcos lineales finos. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico?**

A) Micológico directo con KOH
B) Test de Tzanck
C) Biopsia de piel con inmunofluorescencia
D) IgE total
E) Acarotest: raspado de un surco con observación microscópica del ácaro, huevos o deyecciones

Respuesta E. Prurito nocturno, convivientes afectados, distribución en pliegues interdigitales, muñecas, ombligo y genitales y surcos acarinos sugieren escabiosis. El acarotest (raspado del surco y microscopía) confirma al observar Sarcoptes scabiei, huevos o fecas; tiene alta especificidad pero sensibilidad limitada, por lo que un resultado negativo no descarta y se trata ante clínica sugerente.

6.01.4.002 Dermatoscopía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 16.13 Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatoscopía: examen no invasivo con lente de aumento y luz polarizada o líquido de inmersión que permite ver estructuras pigmentarias invisibles a simple vista; el médico general emplea el informe del especialista.
- Indicaciones: evaluación de lesiones melanocíticas sospechosas (ABCDE, nevo cambiante, «patito feo»), seguimiento de pacientes con múltiples nevos o antecedente familiar, y apoyo en queratosis seborreica, carcinoma basocelular y lesiones vasculares.
- Hallazgos sugerentes de melanoma: retículo pigmentado atípico, velo azul-blanquecino, puntos y glóbulos irregulares, estrías irregulares, regresión; basocelular: vasos arboriformes y glóbulos azul-grisáceos.
- Mejora la sensibilidad y especificidad del examen clínico y orienta qué lesiones biopsiar, pero no reemplaza a la biopsia: el diagnóstico definitivo y el Breslow los entrega la histología.
- Lesión con alta sospecha clínica se biopsia (excisional) sin esperar la dermatoscopía; el informe se usa para decidir derivación, seguimiento digital o extirpación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 40 años con múltiples nevos consulta por un nevo en la espalda que su pareja nota diferente a los demás. Mide 7 mm, es asimétrico, de bordes irregulares y con 2 tonos de marrón. **¿Cuál es la principal utilidad de la dermatoscopía en este caso?**

A) Aumenta la sensibilidad y especificidad del examen clínico para identificar lesiones sospechosas de melanoma y decidir cuáles biopsiar
B) Reemplaza a la biopsia como diagnóstico definitivo de melanoma
C) Mide la profundidad de Breslow
D) Detecta metástasis ganglionares
E) Solo sirve para diagnosticar micosis

Respuesta A. La dermatoscopía es un examen no invasivo con aumento y luz polarizada que permite ver estructuras pigmentarias no visibles a simple vista (retículo atípico, velo azul-blanquecino, puntos irregulares). Mejora la precisión diagnóstica del melanoma respecto al ojo desnudo y orienta qué lesiones extirpar; el diagnóstico definitivo y el Breslow los da la histología.

6.01.4.003 Gram y cultivo

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Gram y cultivo de secreción (piel y partes blandas): se toma pus de un absceso drenado, exudado de herida o ampolla, antes de iniciar el antibiótico, con técnica estéril.
- Indicaciones: abscesos o piodermias recurrentes, extensas o con compromiso sistémico, inmunosuprimidos, falla de tratamiento, sospecha de SAMR comunitario, infección de herida quirúrgica y celulitis con colección. No es necesario en impétigo o celulitis simple.
- Gram: cocos grampositivos en racimos sugieren S. aureus; en cadenas, S. pyogenes; bacilos gramnegativos orientan a Pseudomonas o enterobacterias (pie diabético, tinas calientes).
- Cultivo con antibiograma identifica el agente y su susceptibilidad, incluida la resistencia a meticilina (SAMR) y a clindamicina, y permite dirigir el tratamiento.
- Interpretar y emplear: ajustar antibiótico al resultado (SAMR: cotrimoxazol, clindamicina o vancomicina), no tratar colonización y derivar infecciones graves o de mala evolución.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años con un absceso de 4 cm en el muslo, fluctuante, recurrente por tercera vez en el año. Su pareja tuvo forúnculos recientemente. Se drena en urgencia. **¿Qué examen debe solicitarse de la secreción obtenida y por qué?**

A) Ninguno, el drenaje es suficiente en todos los casos
B) Gram y cultivo con antibiograma, para identificar S. aureus y su susceptibilidad (incluida resistencia a meticilina) por la recurrencia
C) Baciloscopía
D) PCR para virus herpes
E) Micológico directo

Respuesta B. En abscesos y piodermias recurrentes, extensos, con compromiso sistémico, en inmunosuprimidos o con falla de tratamiento, el Gram y el cultivo con antibiograma de la secreción identifican al agente (habitualmente S. aureus) y su susceptibilidad, incluida la resistencia a meticilina comunitaria, lo que orienta el antibiótico y la descolonización.

6.01.4.004 Micológico directo de piel, pelos y uñas

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Micológico directo (KOH): examen de primera línea para tiñas, pitiriasis versicolor, candidiasis y onicomicosis; se complementa con cultivo micológico que identifica el agente.
- Técnica: raspar escamas del borde activo de la lesión (donde están las hifas), pelos rotos (tiña capitis) o detritus subungueal; digerir con KOH 10–20 % y observar al microscopio. Suspender antifúngicos 1–2 semanas antes para evitar falsos negativos.
- Hallazgos: dermatofitos con hifas tabicadas y ramificadas; pitiriasis versicolor con esporas redondas e hifas cortas («albóndigas con espaguetis»); Candida con pseudohifas y levaduras en gemación.
- Muchas distrofias ungueales no son micóticas (psoriasis, liquen, trauma): confirmar con KOH y cultivo antes de usar terbinafina oral 12 semanas.
- Interpretar y emplear: positivo respalda el antifúngico (tópico u oral según localización); si es negativo con alta sospecha, repetir o cultivar.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 35 años consulta por una placa anular de 4 cm en el tronco, pruriginosa, con borde eritematoso descamativo activo y centro más claro, de 3 semanas de evolución. No ha usado ningún tratamiento. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Examen micológico directo con hidróxido de potasio y cultivo de escamas obtenidas del borde activo
B) Biopsia de piel del centro de la lesión
C) Prueba del parche
D) Inmunoglobulina E sérica
E) Cultivo bacteriano de la lesión

Respuesta A. La sospecha es una tiña corporis. Se confirma con micológico directo: se raspan escamas del borde activo, donde están las hifas, y se observan con hidróxido de potasio, complementado con cultivo para identificar la especie. Si el paciente ya usó antifúngicos, conviene suspenderlos 1 a 2 semanas antes para evitar falsos negativos.

6.01.4.005 Patch test

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Patch test (pruebas epicutáneas): examen de confirmación de dermatitis de contacto alérgica (hipersensibilidad tipo IV); los alérgenos se aplican en parches en la espalda.
- Se leen a las 48 horas (al retirar parches) y a las 96 horas: la reacción alérgica persiste o aumenta; la irritativa se desvanece.
- Indicar ante eccema crónico de manos o de localización sugerente, sospecha de alérgeno ocupacional o dermatitis sin causa evidente. Alérgenos frecuentes: níquel, dicromato de potasio, fragancias, conservantes, caucho.
- Debe realizarse con la dermatitis en remisión y sin corticoides sistémicos ni tópicos potentes en la zona; no se indica en dermatitis seborreica ni atópica.
- Interpretar positivo como sensibilización con relevancia clínica solo si coincide con la exposición; en la irritativa es negativo. Emplear el resultado para educar en evitar el alérgeno.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 26 años consulta por lesiones eccematosas muy pruriginosas en el abdomen inferior de 3 semanas de evolución. Al examen se aprecia una placa eritematosa con pequeñas vesículas y excoriaciones por rascado, localizada en la línea media periumbilical inferior, que coincide exactamente con el roce de la hebilla metálica de sus pantalones de mezclilla. Además, refiere que cuando usa aretes de fantasía se le inflaman los lóbulos de las orejas. **¿Cuál es la conducta diagnóstica de confirmación?**

A) Biopsia cutánea urgente
B) Pruebas epicutáneas del parche con lectura a 48 y 96 horas
C) Cultivo de secreción cutánea
D) Examen directo con hidróxido de potasio
E) Determinación de inmunoglobulina E sérica total

Respuesta B. Placa pruriginosa que sobrepasa la zona de contacto con una hebilla metálica, más el antecedente de reacción a bisutería: dermatitis de contacto alérgica por níquel. La confirmación etiológica es la prueba epicutánea del parche con lectura a las 48 y 96 horas.

6.01.4.006 Test TZANCK

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 16.12 Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

QUÉ HAY QUE SABER

- Test de Tzanck: raspado de la base de una vesícula reciente (desbridar el techo), extendido y tinción de Giemsa o Wright para observar queratinocitos acantolíticos y células gigantes multinucleadas.
- Indicación: lesiones vesiculares sospechosas de herpes simple, varicela o herpes zóster; también muestra células acantolíticas en el pénfigo vulgar.

- Limitación: no distingue herpes simple de varicela-zóster y su sensibilidad es moderada (alrededor de 60–70 %); un resultado negativo no descarta infección.
- Es rápido, barato y se hace a la cabecera; hoy la PCR viral en la lesión es el examen de elección cuando está disponible (también permite tipificar).
- Interpretar según contexto: células gigantes multinucleadas en cuadro vesicular agrupado confirman infección herpética; usar el resultado para decidir aciclovir y derivación en inmunosuprimidos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 25 años con vesículas agrupadas sobre base eritematosa en el labio superior, precedidas de ardor. Se realiza raspado de la base de una vesícula reciente con tinción de Giemsa (test de Tzanck). **¿Qué hallazgo se espera y cuál es su principal limitación?**

A) Células gigantes multinucleadas; no distingue entre virus herpes simple y varicela-zóster
B) Hifas tabicadas; no distingue dermatofitos
C) Cocos gram positivos en racimos; no distingue S. aureus de S. epidermidis
D) Ácaros; baja sensibilidad
E) Células de Sézary; requiere citometría

Respuesta A. El test de Tzanck muestra queratinocitos acantolíticos y células gigantes multinucleadas en lesiones por herpes simple y varicela-zóster, pero no diferencia entre ellos y tiene sensibilidad moderada. La PCR viral es hoy el examen de elección. También muestra células acantolíticas en el pénfigo vulgar.

6.01.4.007 VDRL - MHATP

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

QUÉ HAY QUE SABER

- VDRL (no treponémica, cuantitativa) y MHA-TP (treponémica, cualitativa): se interpretan en conjunto para el diagnóstico de sífilis.
- VDRL reactivo + MHA-TP reactivo = sífilis activa: tratar según tiempo de evolución (benzatina 2,4 millones UI IM, 1 dosis si precoz, 3 si tardía o desconocida). VDRL reactivo en título bajo + treponémica no reactiva = falso positivo biológico (LES, embarazo, infecciones virales, edad): no tratar.
- VDRL no reactivo + MHA-TP reactivo = cicatriz serológica de sífilis tratada (o primaria muy precoz): si fue tratada, no tratar; en el embarazo seguir el control con VDRL a las 28–30 semanas. Ambos no reactivos con chancro: período de ventana, repetir en 3 semanas.
- Seguimiento postratamiento solo con VDRL cuantitativo (curación = descenso de 4 veces o 2 diluciones a los 6–12 meses); las treponémicas permanecen positivas de por vida y no sirven para reinfección. En embarazadas con sífilis previa, un VDRL reactivo exige tratar de inmediato.
- Emplear e interpretar: en toda embarazada, ITS o pareja de caso; notificar casos confirmados y estudiar VIH.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Embarazada de 12 semanas en su primer control. VDRL reactivo 1:2. Se solicita MHA-TP, que resulta no reactivo. No tiene lesiones ni antecedentes de sífilis. Tiene diagnóstico reciente de lupus eritematoso sistémico. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A) Sífilis latente precoz; penicilina benzatina
B) Sífilis primaria en período de ventana
C) Sífilis tratada previamente (cicatriz serológica)
D) Falso positivo biológico del VDRL, probablemente asociado al lupus
E) Neurosífilis

Respuesta D. El VDRL es una prueba no treponémica, sensible y útil para seguimiento, pero con falsos positivos (habitualmente títulos bajos) en LES, síndrome antifosfolípido, embarazo, infecciones virales y otras. Las pruebas treponémicas (MHA-TP, FTA-Abs) confirman y quedan positivas de por vida. VDRL reactivo con treponémica negativa es un falso positivo biológico.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 1 códigos

6.01.5.001 Biopsia de piel

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 16.11 Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) · Tema 16.13 Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Biopsia de piel: procedimiento que se deriva a especialista; el médico general conoce indicaciones y el tipo de muestra requerida.
- Indicaciones: sospecha de melanoma o lesión pigmentada cambiante, cáncer de piel no melanoma, dermatosis ampollares (pénfigo y penfigoide), vasculitis, lupus cutáneo, linfoma cutáneo, y lesiones crónicas que no responden al tratamiento.
- Melanoma: biopsia excisional completa con margen de 1–2 mm hasta la hipodermis; shave o punch superficial contraindicados. Ampollares: ampolla reciente (histología) + piel perilesional sana para inmunofluorescencia directa; no biopsiar erosiones antiguas.
- Antes de derivar: indicar al paciente que mantenga la lesión sin manipular, registrar localización y tamaño, y evaluar anticoagulantes, alergia a anestésicos y cicatrización queloidea.
- Derivar a dermatología o cirugía con pedido de histología (y de inmunofluorescencia si corresponde); ante sospecha de melanoma, derivar con carácter preferente.

PREGUNTAS (4)

Pregunta de práctica

Un hombre de 46 años consulta por un nevo en la espalda que ha cambiado de color y aumentado de tamaño en los últimos 4 meses. Al examen se observa una lesión macular asimétrica de 8 mm con bordes irregulares y tres colores distintos (café claro, negro y grisáceo). **¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección?**

A) Cauterización con nitrógeno líquido (crioterapia) en la consulta
B) Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen lateral y celular subcutáneo
C) Biopsia por afeitado (shave) superficial para no dejar cicatriz antiestética
D) Biopsia por sacabocados (punch) de 2 mm tomada del centro más pigmentado de la lesión
E) Control fotográfico digital seriado cada 3 meses

Respuesta B. Ante una lesión con sospecha clínica de melanoma maligno, el estándar de oro diagnóstico es la biopsia excisional completa con márgenes estrechos de 1 a 2 mm y en toda la profundidad del tejido celular subcutáneo, lo que permite medir el espesor de Breslow sin desestructurar la lesión.

Pregunta de práctica

Hombre de 72 años presenta hace 3 semanas ampollas tensas de contenido seroso sobre placas eritematosas en el abdomen y las caras internas de los muslos, con prurito intenso y sin compromiso de mucosas. Se sospecha una enfermedad ampollar autoinmune. **¿Cuál es el estudio más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Cultivo del contenido de la ampolla
B) Biopsia de una ampolla reciente para histología y biopsia de piel perilesional para inmunofluorescencia directa
C) Test de Tzanck
D) Biopsia del centro de una erosión antigua
E) Examen micológico directo

Respuesta B. En enfermedades ampollares autoinmunes se toman dos muestras: una ampolla reciente e intacta para histología, que muestra el nivel de separación, y piel perilesional sana para inmunofluorescencia directa, que muestra el depósito de anticuerpos. Las erosiones antiguas no sirven porque el tejido está destruido.

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años consulta por una lesión pigmentada en la pantorrilla izquierda, de 5 meses de evolución, con crecimiento progresivo y prurito ocasional. Al examen se observa una mácula de 8 mm de diámetro mayor, asimétrica, de bordes irregulares, con tonalidades café oscuro, negro y un área grisácea central. No se palpan adenopatías inguinales. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A) Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen y tejido celular subcutáneo
B) Biopsia por sacabocados (punch) del área más pigmentada
C) Crioterapia con nitrógeno líquido en la misma consulta
D) Control fotográfico digital seriado en 6 meses
E) Biopsia por afeitado (shave) superficial

Respuesta A. La lesión cumple los cinco criterios del ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color heterogéneo, diámetro mayor a 6 mm y evolución en 5 meses. Ante esa sospecha, la conducta obligatoria es la biopsia excisional completa con margen estrecho e hipodermis, que permite medir el Breslow real. El punch y el shave subestiman el espesor; la crioterapia y el control diferido retrasan el diagnóstico de un posible cáncer.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 114 · texto original del banco, sin revisar

Adulto mayor con Alzheimer presenta lesiones ulceradas en la pierna de aspecto sospechoso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar antibiótico tópico y cubrir
B) Curación avanzada con alginato de calcio
C) Solicitar Doppler venoso de extremidades
D) Tomar biopsia de las lesiones
E) Derivar a dermatología en control habitual

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Tomar biopsia de las lesiones (opción D). Tomar biopsia de las lesiones. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.